



ZLECAf

TRADE INTELLIGENCE · RAPPORTS SECTORIELS

RAPPORT SECTORIEL N° 03

Édition T3 2026 · mise à jour trimestrielle

Pharmaceutique & Santé

*Tarifs préférentiels, produits exemptés et accès
aux médicaments dans la ZLECAf*

15 segments santé : principes actifs, médicaments, vaccins, diagnostics, dispositifs

Étude de cas : Maurice, zones franches et régime ZLECAf · statut GAFI

Focus Algérie : industrie, export vers l'Afrique, calculs et scénarios

Données SaaS ZLECAf croisées avec OMS, GAFI, BACI, Banque d'Algérie, MRA, tralac

15

segments de produits
de santé

5 463

lignes tarifaires santé
(40 barèmes nationaux)

0

médicament ou principe actif
en liste d'exclusion (offres)

54

pays couverts

À PROPOS DE CE RAPPORT

Un rapport construit sur les données du SaaS ZLECAf, croisées avec les sources officielles et la presse les plus récentes

Ce rapport sectoriel est produit par ZLECAf Trade Intelligence à partir de la plateforme SaaS ZLECAf : barèmes tarifaires nationaux, offres officielles de l'e-Tariff Book de l'Union africaine, règles d'origine de l'Appendice IV, registre d'application bilatérale, calculateurs de taux préférentiels, calculateur fiscal algérien et module Opportunités (dont le sous-module « Algérie · industrie et marchés »). Ces données sont croisées avec les sources publiques de référence (GAFI, OMS, Africa CDC, UN Comtrade, BACI, OMC, EUR-Lex, Secrétariat de la ZLECAf, Banque d'Algérie, EDB et MRA de Maurice) et avec la presse économique, citée dans le texte avec sa date, arrêtées au 27 septembre 2026.

Il s'adresse aux industriels du médicament et des dispositifs médicaux, aux distributeurs, aux centrales d'achat, aux investisseurs, aux banques et assureurs du commerce, ainsi qu'aux administrations. Il est mis à jour chaque trimestre.

Périmètre : 15 segments de santé

N°	Segment	Positions SH
01	Principes actifs & intermédiaires	2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941
02	Sang, vaccins, immunologiques	3001, 3002
03	Médicaments en vrac	3003
04	Médicaments dosés (conditionnés)	3004
05	Pansements & articles pharmaceutiques	3005, 3006
06	Réactifs de diagnostic	3822
07	Désinfectants & antiseptiques	380894, 220710, 220890
08	Gants & consommables caoutchouc	401511, 401512, 401519, 4014
09	Instruments & appareils médicaux	9018, 9019, 9020
10	Orthopédie, implants & prothèses	9021
11	Imagerie & radiologie	9022
12	Mobilier médical	9402
13	Hygiène (serviettes, couches)	9619
14	Emballages pharmaceutiques	701090, 701010, 392330, 392350, 392310
15	Masques & textiles médicaux	630790, 621010

Comment lire les taux de ce rapport

NPF : droit de douane de la nation la plus favorisée, appliqué à toute origine sans préférence.

Offre ZLECAf : calendrier publié dans l'e-Tariff Book, indicatif tant que la destination ne l'a pas mis en œuvre.

Taux servi : taux calculé par les modules du SaaS lorsque la préférence est juridiquement opposable (acte national en vigueur, origine admise, ligne couverte). En 2026, cela concerne cinq destinations : Algérie, Égypte, Kenya, Maroc et SACU.

Charge hors TVA : droit de douane et prélèvements définitifs ; la TVA, récupérable ou exonérée pour les médicaments, est présentée à part.

Avertissement

Ce document est une analyse économique et réglementaire. Il ne constitue ni un avis juridique, ni une décision de classement ou de valeur en douane, ni un avis médical. Les taux doivent être confirmés ligne par ligne dans le calculateur ZLECAf et auprès de l'administration des douanes de destination avant toute opération. Les informations de presse sont citées avec leur date ; celles qui n'ont pas pu être confirmées en source primaire sont signalées comme telles.

SOMMAIRE

Table des matières

Synthèse exécutive	5
1. Le marché africain des produits de santé	7
1.1 Un marché mal mesuré, mais en forte croissance	7
1.2 Qui produit en Afrique ?	8
1.3 Vaccins, achats groupés et préqualification	8
2. Cadre ZLECAf et régulation pharmaceutique	9
2.1 Les engagements tarifaires	9
2.2 L'Agence africaine du médicament et la confiance réglementaire	9
2.3 Les obstacles non tarifaires	9
3. Droits NPF sur les produits de santé	10
3.1 Cartographie : 10 régimes × 15 segments	10
3.2 Structure par segment : où se trouvent les droits	11
3.3 « Produits exemptés » : trois réalités à ne pas confondre	12
4. Offres ZLECAf et préférences réellement servies	13
4.1 Les offres : la santé en catégorie A, sans exception	13
4.2 Des offres aux préférences servies	15
4.3 Lecture : où la préférence crée-t-elle une marge ?	16
5. Règles d'origine : ce qui rend un médicament « africain »	17
5.1 Trois pièges à éviter	17
6. Opportunités par segment	18
6.1 Trois opportunités où la ZLECAf fait la différence	18
6.2 Trois opportunités où la ZLECAf ne joue pas, mais le marché si	18
7. Étude de cas : Maurice, zones franches et ZLECAf	19
7.1 De l'EPZ au Freeport : un modèle qui s'est normalisé	19
7.2 La santé à Maurice : un hub de dispositifs, pas (encore) de médicaments	20
7.3 La ZLECAf exclut-elle les zones franches ? Non, elle les encadre	21
7.4 Les autres accords de Maurice : même logique d'encadrement	22
7.5 Fiscalité et change : l'avantage mauricien face à la ZLECAf	22
7.6 GAFI : la sortie de liste grise, un actif de conformité	23
7.7 Scénario chiffré : un cathéter mauricien vers l'Algérie	24
8. Focus Algérie : de la substitution à l'export	25
8.1 Une base industrielle devenue significative	25
8.2 Le régime à l'importation : ce que la ZLECAf change pour l'industriel algérien	27
8.3 Hypothèse de travail n° 1 : la protection effective négative	27
8.4 Les marchés d'exportation : où la demande et la préférence se rencontrent	29
8.5 Cas chiffré : génériques algériens contre génériques indiens à Dakar	31
8.6 Contraintes financières et de conformité	32
8.7 Scénarios 2027 pour les exportations pharmaceutiques	32
9. Turbulences politiques et chaînes d'approvisionnement	33

9.1 Algérie-Sahel : du gel d'avril 2025 à la normalisation de 2026	33
9.2 Voisinage et grands partenaires : une carte en recomposition	34
9.3 Instabilité en Afrique : où le risque politique touche le médicament	35
9.4 Chocs extérieurs : quatre décisions qui redessinent le marché	35
9.5 Matrice de risque des marchés cibles pour l'exportateur algérien	36
10. Recommandations	37
Annexe 1 — Tableau de bord santé des 54 pays	38
Annexe 2 — Note méthodologique	40
Annexe 3 — Lexique	41

SYNTHÈSE

Synthèse exécutive

Dans la santé, la ZLECAf ne se joue pas là où on l'attend. Les médicaments entrent déjà presque partout à droit nul ; la préférence continentale compte surtout sur les intrants, les dispositifs et les consommables. Le vrai verrou est réglementaire et financier. Dix messages pour décider.

17-20 Md\$

importations africaines de produits pharmaceutiques par an ; ~ 5 % seulement viennent d'Afrique
UN Comtrade 2022-2024

31 / 40

barèmes nationaux à droit nul sur les médicaments dosés
SaaS ZLECAF

0

médicament ou principe actif en liste d'exclusion dans les 10 offres étudiées
e-Tariff Book via SaaS

83 %

couverture du marché algérien par la production locale (fin 2025)
ANPP, 22/02/2026

- 1. Un marché de substitution.** L'Afrique importe plus de 70 % de ses médicaments et 99 % de ses vaccins ; l'Inde (29 %) et l'Europe (45-50 %) la fournissent, le commerce intra-africain ne pèse que 0,79 Md USD.
- 2. Le médicament fini est déjà détaxé.** 31 barèmes sur 40 appliquent 0 % aux médicaments dosés ; la ZLECAf n'y crée aucune marge. Les exceptions : Maroc (jusqu'à 25 %), CEMAC, Algérie et Éthiopie (5 %).
- 3. Pas de médicament « exempté » de la ZLECAf.** Sur 780 lignes pharma des offres, 776 sont en catégorie A (4 non renseignées). Les exclusions visent l'alcool, les emballages plastiques et verre, l'hygiène.
- 4. La marge est dans les intrants et les dispositifs.** En Algérie, les antibiotiques en vrac (15 %) sont plus taxés que le médicament fini (5 %) ; seringues, gants et lits médicaux paient 32 à 65 % hors TVA, ramenés à 2-5 % sous ZLECAf.
- 5. L'origine est accessible.** Un comprimé formulé en Afrique avec un API indien ou chinois est originaire (changement de position). Le simple reconditionnement ne l'est jamais.
- 6. Les zones franches ne sont pas exclues.** Contrairement à une idée répandue, l'Annexe 2 (art. 9) et le règlement 1/2023 admettent les produits de ZES aux préférences, sous conditions de notification, d'enregistrement et de garde-fous.
- 7. Maurice : un hub de dispositifs, pas de médicaments.** 6 fabricants, 49 M USD d'exportations de dispositifs (2024), IS de 3 %, pas de contrôle des changes depuis 1994 ; sortie de la liste grise du GAFI dès octobre 2021.
- 8. L'Algérie change de statut.** Sortie de la liste grise du GAFI le 19/06/2026, niveau 3 de l'OMS en cours d'évaluation, normalisation avec le Niger (février) et le Mali (juillet 2026) : l'export devient crédible.
- 9. La proximité vaut 1,3 à 3 % du prix.** Face à l'Inde à Dakar, l'avantage logistique algérien ne compense pas un écart de prix industriel ; il décide sur les produits volumineux et en temps de crise maritime.
- 10. Le verrou est réglementaire et financier.** Enregistrement, délai de rapatriement de 120 jours, liste UE des pays à haut risque : ce sont eux, plus que le tarif, qui fixent le rythme de l'export.

Focus Algérie : ce qu'il faut retenir

Industrie : 233 sites, 83 % de couverture, facture d'import ramenée de 2 Md USD (2019) à 515 M USD (2024) ; exportations de médicaments dosés de 23,3 M USD en 2024, surtout vers l'Arabie saoudite (insuline de Boufarik).

Importer mieux : un API d'origine égyptienne ou tunisienne peut coûter jusqu'à 14,7 % de plus qu'un API asiatique avant de perdre son avantage ; la protection effective de la formulation passe de -3 % à +12 % (API = 50 % du prix).

Exporter : cibles prioritaires Mauritanie, Tunisie, puis Niger, Sénégal, Côte d'Ivoire ; le Maroc, seul marché à forte marge ZLECAf, reste fermé ; le Kenya n'admet pas l'origine algérienne.

Conditions : niveau 3 de l'OMS pour l'ANPP, assurance-crédit CAGEX pour porter le rapatriement à 180 jours, élargissement de la liste des partenaires ZLECAf admis.

Focus Maurice et zones franches

La ZLECAf traite la zone franche comme une partie du territoire : le produit qui en sort vers un autre État partie peut être originaire et préférentiel. En droit national, la même sortie vers le marché intérieur est une importation. Fiscalité et change restent souverains, mais un avantage lié à l'exportation s'expose aux droits compensateurs (Annexe 9).

Exemple : un cathéter mauricien (SH 9018.39) entre en Algérie à 2 % de charge hors TVA contre 32 % pour une origine tierce, soit une marge de 30 points.

CHAPITRE 1

Le marché africain des produits de santé

L'Afrique consomme des médicaments qu'elle ne produit pas. Elle importe plus de 70 % de ses médicaments et environ 99 % de ses vaccins, et le commerce pharmaceutique entre pays africains ne pèse qu'environ 5 % de ses importations. C'est la définition même d'un marché de substitution, que la ZLECAf, l'Agence africaine du médicament et les achats groupés cherchent à ouvrir aux producteurs du continent.

17-20 Md\$

importations africaines de produits pharmaceutiques (SH 30) par an

UN Comtrade, calcul sur déclarations 2022-2024

≈ 5 %

part du commerce intra-africain dans ces importations (0,79 Md USD en 2024)

UN Comtrade, extraction 27/09/2026

70 % / 99 %

part importée des médicaments / des vaccins

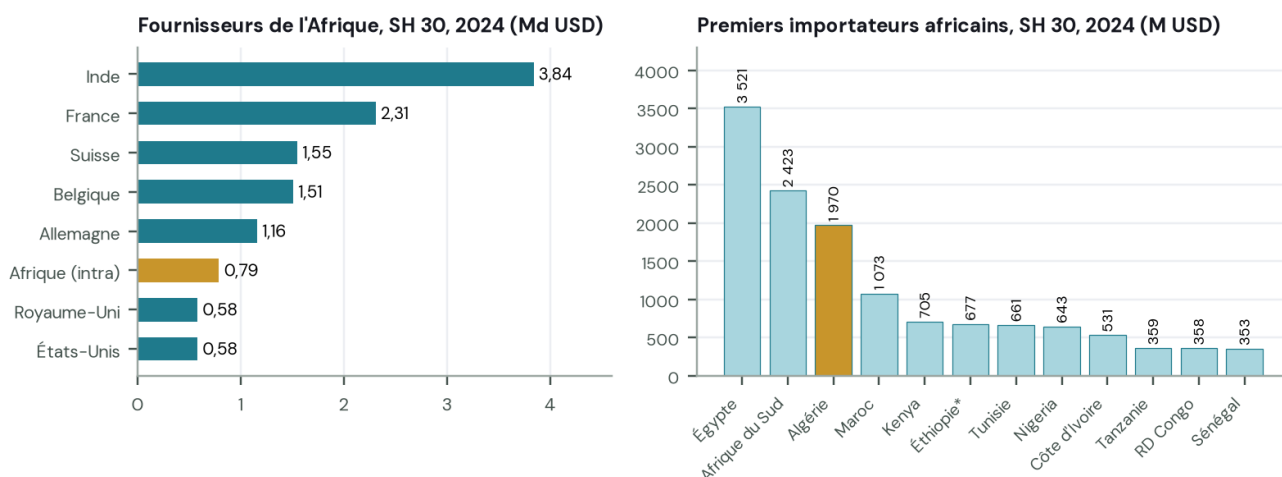
Gavi (2025) ; OMS AFRO (22/07/2024)

9,0 Md\$

importations de médicaments dosés SH 3004.90 seuls (2024)

BACI via SaaS, module Opportunités

Figure 1.1 — D'où viennent les médicaments de l'Afrique, et qui les achète



Source : UN Comtrade (données miroir et déclarations des pays africains, extraction du 27/09/2026, calcul ZLECAf Trade Intelligence). *Éthiopie : 2023. Chine : 0,97 Md USD en 2023 (non disponible pour 2024), mais premier fournisseur de principes actifs.

1.1 Un marché mal mesuré, mais en forte croissance

Il n'existe pas de chiffre unique de la taille du marché africain du médicament : selon le périmètre (prix fabricant ou public, médicaments seuls ou avec dispositifs), les cabinets privés l'estiment entre **29 et 64 Md USD en 2025**, avec une croissance de 6 à 9 % par an jusqu'en 2030-2032 (Persistence Market Research, 2025 ; ResearchAndMarkets, 23/07/2025). L'Égypte en est le premier marché (8,4 Md USD en 2025, selon Zawya), devant l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Algérie (4 à 4,7 Md USD, selon Maghreb Pharma, 21/05/2025). IQVIA prévoit pour l'Afrique la plus forte croissance en volume au monde, portée par la démographie et l'élargissement de l'accès aux soins (10/2024).

Les fournisseurs. En valeur, l'Union européenne fournit 45 à 50 % des médicaments importés (France 17 %, Belgique 11 %, Allemagne 9 %), l'Inde 29 % et la Suisse 12 %. Le chiffre indien de « 40 % » souvent cité par la presse (AFP, 2026) correspond vraisemblablement aux volumes : l'Inde domine les génériques bon marché, l'Europe les spécialités. La Chine pèse peu dans les médicaments finis (7 %) mais fournit l'essentiel des principes actifs, y compris ceux de l'Inde, qui en dépend pour 65 à 70 % (ORF).

1.2 Qui produit en Afrique ?

Tableau 1.1 — Les principaux producteurs africains

Pays	Exportations pharma	Positionnement	Source
Afrique du Sud	538 M USD (SH 30, 2024), 41 % des exportations intra-africaines	Aspen (premier génériqueur du continent), Biovac (vaccins)	UN Comtrade ; Aspen ; Semafor, 02/07/2026
Égypte	1,3 Md USD en 2025 selon l'EDA (0,45 Md USD en SH 30 strict) ; objectif 3 Md USD en 2030	~80 % d'autosuffisance ; Eva Pharma (licence Eli Lilly)	TV BRICS, 22/04/2026 ; Daily News Egypt, 24/08/2025
Maroc	171 M USD en 2025 ; déficit pharma de 1,1 Md USD	Objectif de 1 Md USD d'exportations par an	Morocco World News, 09/2026
Kenya	175 M USD (SH 30, 2024), 22 % des exportations intra-africaines	Hub de la CAE	UN Comtrade
Tunisie	128 M USD (SH 30, 2024)	Génériques, sous-traitance européenne	UN Comtrade
Algérie	23,3 M USD de médicaments dosés (2024), dont 80,9 % vers l'Arabie saoudite	83 % de couverture du marché national ; 233 sites	BACI via SaaS ; ANPP, 22/02/2026

Les périmètres diffèrent (SH 30 strict, déclarations nationales, chiffres d'agence) : les comparaisons entre pays sont des ordres de grandeur.

Un paradoxe algérien. L'Algérie est le troisième importateur africain de produits pharmaceutiques au sens large (1,97 Md USD en SH 30 en 2024, UN Comtrade) alors que sa facture d'importation de « médicaments » n'est plus que de 515 M USD selon la presse nationale (Horizons, 01/02/2026). L'écart tient au périmètre : le SH 30 comprend les vaccins, les produits du sang, les insulines et les médicaments innovants, que les chiffres officiels de substitution ne couvrent pas tous. Pour un fournisseur africain, c'est ce segment de produits à forte valeur, encore importés, qui constitue le vrai marché algérien.

1.3 Vaccins, achats groupés et préqualification

- **Vaccins** : l'Union africaine vise 60 % de production locale en 2040 ; le jalon de 10 % en 2025 n'a pas été atteint. L'accélérateur AVMA de Gavi (lancé en juin 2024) mobilise jusqu'à 1,2 Md USD sur dix ans ; premiers décaissements attendus au second semestre 2026 (Gavi ; Semafor, 02/07/2026).
- **Achats groupés** : le premier appel d'offres du Mécanisme africain d'achats groupés d'Africa CDC (résultats du 12/05/2026) a porté sur 10 produits de santé maternelle et infantile pour 10 pays, avec des **économies de 30 à 90 %** ; 5 des 10 produits impliquent des fabricants africains. Afreximbank et Africa CDC y adossent une facilité de 2 Md USD.
- **Préqualification OMS** : elle ouvre les achats des agences de l'ONU et du Fonds mondial. Aucun décompte consolidé des fabricants africains préqualifiés n'est publié ; MMV en a accompagné 3 pour les antipaludiques et en vise 7 d'ici 2030.
- **Qualité** : environ 1 produit médical sur 10 est de qualité inférieure ou falsifié dans les pays à revenu faible et intermédiaire (OMS) ; les méta-analyses africaines avancent 18,7 à 22,6 %. L'opération Pangea XVIII d'Interpol (mars 2026, 90 pays) a saisi 6,42 millions de doses, dont des antibiotiques et antipaludiques dans 12 pays africains. Une production locale certifiée est aussi une réponse de santé publique.

CHAPITRE 2

Cadre ZLECAf et régulation pharmaceutique

Trois étages de règles déterminent l'accès d'un médicament à un marché africain : le droit de douane (ZLECAf et tarifs nationaux), l'origine (Annexe 2), et, surtout, l'autorisation de mise sur le marché, qui relève encore de 54 autorités nationales en voie d'harmonisation par l'Agence africaine du médicament.

2.1 Les engagements tarifaires

Les modalités de négociation prévoient la libéralisation de **90 % des lignes** (catégorie A) en 5 ans (10 ans pour les pays les moins avancés), de 7 % de lignes sensibles en 10 ans (13 pour les PMA) et l'exclusion d'au plus 3 % des lignes, dans la limite de 10 % des importations. Les produits pharmaceutiques figurent parmi les chaînes de valeur prioritaires de l'Accord et parmi les produits de l'Initiative de commerce guidé, passée de 7 à 39 pays participants en septembre 2024 (IISD, 2024). Aucun pays africain n'est membre de l'accord « zéro pour zéro » de l'OMC sur les produits pharmaceutiques (1995) ; plusieurs ont néanmoins supprimé leurs droits de façon autonome (Nigeria et Ghana dès 2018).

La mise en œuvre reste partielle. Au 27 septembre 2026, le registre d'application du SaaS n'identifie que cinq destinations où un taux préférentiel est opposable, ligne par ligne et pour des origines nommées : Afrique du Sud (SACU), Algérie, Égypte, Kenya et Maroc (chapitre 4). Le Protocole sur l'investissement, adopté en février 2023, attend encore ses ratifications.

2.2 L'Agence africaine du médicament et la confiance réglementaire

Tableau 2.1 — Architecture réglementaire africaine

Élément	Situation (septembre 2026)	Source
Traité AMA	En vigueur depuis le 05/11/2021 ; 32 à 33 ratifications en 2026 selon les sources ; accord-cadre OMS-AMA signé le 21/05/2026	Site AMA ; Health Policy Watch ; OMS, 21/05/2026
Siège et direction	Kigali ; Dr Delese Mimi Darko, directrice générale depuis juin 2025	UA, 04/06/2025
Compétences transférées	Harmonisation réglementaire (AMRH) et surveillance de la sécurité, reprises d'AUDA-NEPAD en janvier 2026	ACRN, 13/08/2026
Régulateurs au niveau 3 de l'OMS	10 : Afrique du Sud, Égypte, Éthiopie, Ghana, Mozambique (08/2026), Nigeria, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Zimbabwe	OMS, 24/08/2026 et 30/09/2025
Algérie	Ratification du traité AMA (2021) ; évaluation de l'ANPP au niveau 3 engagée à partir de septembre 2026	El Watan, 10/06/2021 ; L'Algérie Aujourd'hui, 07/06/2026
Maurice	Ratification du traité AMA ; pas d'agence autonome du médicament	OMS AFRO, 25/07/2025 ; OMC 2021
Capacité réglementaire	40 des 47 autorités de la région AFRO n'exercent pas toutes les fonctions réglementaires	OMS AFRO, 25/07/2025

Sources citées. La liste des régulateurs de niveau 3 est celle publiée par l'OMS au 24/08/2026.

Pourquoi le niveau 3 de l'OMS compte plus que la ZLECAf pour l'exportateur

Un médicament ne franchit pas une frontière africaine sans autorisation de mise sur le marché. Un régulateur reconnu au niveau 3 ouvre la voie aux procédures fondées sur la confiance (« reliance ») : le pays importateur s'appuie sur l'évaluation d'un régulateur de référence, ce qui ramène le délai d'enregistrement de plusieurs années à quelques mois. Pour l'Algérie, l'aboutissement de l'évaluation de l'ANPP, engagée en septembre 2026, vaut davantage que tout point de droit de douane.

2.3 Les obstacles non tarifaires

Par ordre d'importance : **l'enregistrement** (dossiers CTD nationaux multiples, 12 à 36 mois, redevances) ; les **inspections BPF** redondantes ; les **prix administrés** (Algérie, Maroc, Égypte, Tunisie), qui fixent la rentabilité avant le droit de douane ; la **préférence nationale** dans les achats publics et les programmes d'importation ; enfin les **paiements** (délais publics de 90 à 180 jours, contrôle des changes, diligences renforcées dans les pays sous surveillance du GAFI).

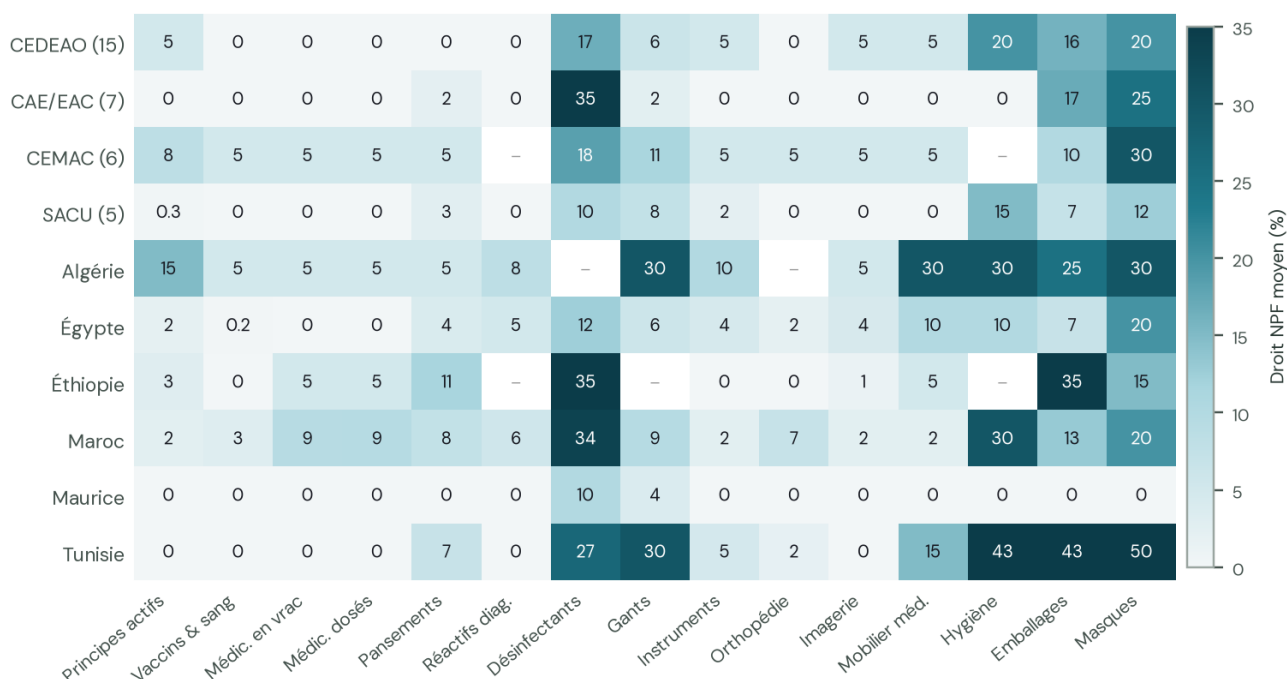
CHAPITRE 3

Droits NPF sur les produits de santé

Premier constat, contre-intuitif pour qui connaît les barèmes agricoles : l'Afrique taxe peu les médicaments à l'entrée. Sur les 40 barèmes nationaux du SaaS (5 463 lignes SH6 relevant des 15 segments santé), 31 appliquent un droit nul sur les médicaments dosés. La protection se loge ailleurs : dans les consommables (gants, seringues, masques), l'hygiène, les emballages et les désinfectants, où les droits atteignent 30 à 50 %.

3.1 Cartographie : 10 régimes × 15 segments

Figure 3.1 — Droit NPF moyen par segment de santé et par régime tarifaire (%)



Source : SaaS ZLECAF, barèmes nationaux (droit NPF appliqué, moyenne simple des lignes SH6 du segment). Le chiffre entre parenthèses indique le nombre d'États appliquant le tarif extérieur commun. « – » : aucune ligne publiée pour ce segment. Maroc : barème national du SaaS (sous-positions nationales, jusqu'à 17,5 % sur les médicaments fabriqués localement).

Trois familles de régimes se dessinent. (i) **Franchise quasi totale** sur les médicaments : CEDEAO (TEC catégorie O), CAE, SACU, Maurice, Tunisie et Égypte. (ii) **Droit plancher de 5 %** : CEMAC, Algérie, Éthiopie, niveau qui renchérit le médicament sans réelle fonction de protection. (iii) **Protection ciblée** : le Maroc module le droit selon que la spécialité est fabriquée localement (10 à 25 %) ou non (2,5 %), faisant du tarif un instrument de politique industrielle. Dans ce paysage, la valeur ajoutée de la ZLECAF ne se mesure pas au droit supprimé sur les médicaments (souvent déjà nul), mais sur les **intrants** (principes actifs, emballages) et les **dispositifs et consommables**.

3.2 Structure par segment : où se trouvent les droits

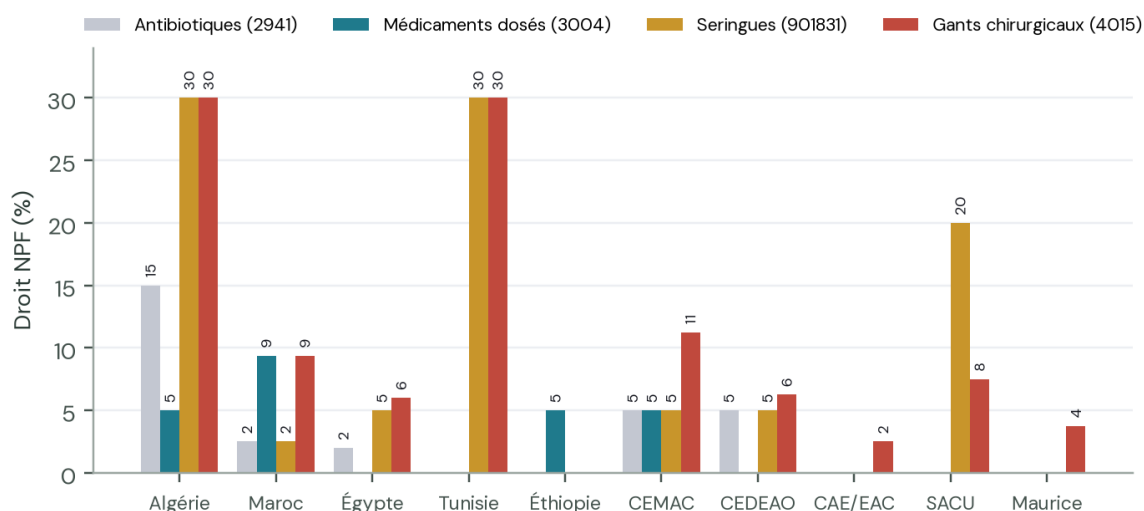
Tableau 3.1 — Droits NPF par segment, 40 barèmes

Segment	Positions SH	Pays à 0 %	Moy. 40 pays	Maximum (pays)
Principes actifs & intermédiaires	2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941	10/40	3,7 %	15,0 % (DZA)
Sang, vaccins, immunologiques	3001, 3002	31/40	1,0 %	5,0 % (CAF)
Médicaments en vrac	3003	31/40	1,2 %	9,2 % (MAR)
Médicaments dosés (conditionnés)	3004	31/40	1,2 %	9,4 % (MAR)
Pansements & articles pharmaceutiques	3005, 3006	16/40	2,4 %	11,4 % (ETH)
Réactifs de diagnostic	3822	30/33	0,6 %	8,3 % (DZA)
Désinfectants & antiseptiques	380894, 220710, 220890	0/39	20,4 %	35,0 % (BDI)
Gants & consommables caoutchouc	401511, 401512, 401519, 4014	0/39	7,6 %	30,0 % (DZA)
Instruments & appareils médicaux	9018, 9019, 9020	10/40	3,4 %	10,0 % (DZA)
Orthopédie, implants & prothèses	9021	30/39	1,0 %	6,9 % (MAR)
Imagerie & radiologie	9022	15/40	3,0 %	5,0 % (BEN)
Mobilier médical	9402	14/40	4,2 %	30,0 % (DZA)
Hygiène (serviettes, couches)	9619	9/33	14,8 %	43,0 % (TUN)
Emballages pharmaceutiques	701090, 701010, 392330, 392350, 392310	1/40	14,8 %	43,0 % (TUN)
Masques & textiles médicaux	630790, 621010	1/40	21,9 %	50,0 % (TUN)

Source : SaaS ZLECAF. Moyenne simple des moyennes nationales. Codes ISO3 : DZA Algérie, MAR Maroc, TUN Tunisie, ETH Éthiopie, BDI Burundi, BEN Bénin, CAF Centrafrique.

L'escalade à rebours. La logique tarifaire classique veut qu'un pays taxe peu ses intrants et davantage ses produits finis. Dans la santé, plusieurs barèmes font l'inverse : **l'Algérie taxe les antibiotiques en vrac (SH 2941) à 15 %** et les médicaments finis à 5 %. La CEMAC et la CEDEAO appliquent 5 % aux principes actifs et 0 à 5 % aux médicaments. Cette **protection effective négative** pénalise la formulation locale face à l'importation de produits finis (calcul au chapitre 8).

Figure 3.2 — Principes actifs, médicaments, seringues et gants : quatre niveaux de droit NPF (%)



Source : SaaS ZLECAF. Antibiotiques : moyenne des lignes SH 2941 ; seringues : SH 9018.31 ; gants : SH 4015.11/12/19 et 4014.

3.3 « Produits exemptés » : trois réalités à ne pas confondre

Le terme recouvre trois mécanismes juridiques distincts, dont les effets économiques diffèrent radicalement :

Notion	Base juridique	Ce que cela signifie	Dans la santé
Exclusion de la libéralisation (catégorie C)	Protocole commerce des marchandises, art. 7 ; Modalités (3 % des lignes, 10 % des importations)	La ligne conserve le droit NPF ; aucune préférence ZLECAF, jamais.	Aucun médicament, vaccin ni principe actif dans les 10 offres étudiées. Seuls l'alcool éthylique, les déchets pharmaceutiques (CEMAC), certains emballages et articles d'hygiène.
Produit sensible (catégorie B)	Idem (7 % des lignes) ; démantèlement en 10 à 13 ans	Préférence différée : 0 % atteint en 2030–2033 (pays en développement), 2035 (PMA).	Alcool à usage médical (CEMAC, Égypte), flacons et bouchons plastiques (CEMAC, Éthiopie, Tunisie), tenues de protection (Égypte), articles d'hygiène (Éthiopie, Égypte).
Exonération nationale (droit NPF nul, TVA exonérée)	Tarif national, TEC, code des impôts	Le produit entre déjà à 0 % de droit, pour tous les pays du monde.	31 barèmes sur 40 à 0 % sur les médicaments dosés. La ZLECAF n'apporte alors aucune marge tarifaire.

Source : Accord ZLECAF (Protocole sur le commerce des marchandises), Modalités de négociation tarifaire (2019), e-Tariff Book (UA), SaaS ZLECAF.

Implication pour un exportateur de médicaments

Sur la plupart des marchés africains, la ZLECAF ne crée **aucune marge tarifaire** sur le médicament fini : le concurrent indien, chinois ou européen paie déjà 0 %. L'avantage compétitif africain doit donc venir d'ailleurs : proximité (délai, stock, fret), reconnaissance réglementaire, achats groupés, prix et financement. Les exceptions où la préférence compte vraiment sont le **Maroc** (jusqu'à 25 % de droit NPF), la **CEMAC**, l'**Algérie** et l'**Éthiopie** (5 %), ainsi que les **dispositifs et consommables** partout où ils sont taxés à 10–35 %.

CHAPITRE 4

Offres ZLECAf et préférences réellement servies

Les offres tarifaires déposées à l'Union africaine (e-Tariff Book) classent chaque ligne en catégorie A (démantèlement en 5 ans, 10 ans pour les PMA), B (sensible) ou C (exclue). Mais une offre n'est pas une préférence : il faut encore que la destination l'ait transposée en droit interne et qu'elle admette l'origine de l'exportateur. Ce chapitre distingue les deux niveaux.

4.1 Les offres : la santé en catégorie A, sans exception

Tableau 4.1 — Catégorie des lignes de santé dans les offres e-Tariff Book

Offre	Principes actifs	Vaccins, sang	Médic. vrac	Médic. dosés	Pansements	Instruments	Lignes B/C (santé)
CEMAC	46/46 A	12/12 A	10/10 A	12/12 A	11/12 A	16/16 A	10
CAE	46/46 A	11/11 A	10/10 A	12/12 A	12/12 A	16/16 A	0
CEDEAO	46/46 A	12/12 A	10/10 A	9/13 A	11/11 A	17/17 A	0
Égypte	46/46 A	12/12 A	20/20 A	24/24 A	12/12 A	17/17 A	6
Éthiopie	46/46 A	13/13 A	11/11 A	13/13 A	11/11 A	16/16 A	12
Maroc	hors extrait	38/38 A	31/31 A	97/97 A	292/292 A	27/27 A	0
Tunisie	hors extrait	17/17 A	20/20 A	24/24 A	21/21 A	37/37 A	7
Zambie	hors extrait	13/13 A	10/10 A	12/12 A	15/15 A	16/16 A	0
Zimbabwe	46/46 A	12/12 A	14/14 A	21/21 A	11/11 A	18/18 A	0

Source : SaaS ZLECAf, instantanés e-Tariff Book (collectés les 17/08 et 13/09/2026). « n/t A » : n lignes en catégorie A sur t lignes du segment. CEDEAO : 4 lignes de médicaments dosés sans catégorie renseignée. « Hors extrait » : chapitre 29 absent de l'instantané (Maroc, Tunisie, Zambie).

Sur 780 lignes de principes actifs, vaccins et médicaments recensées dans les offres, **776 sont en catégorie A et 4 ne sont pas renseignées ; aucune n'est sensible ou exclue**. Les lignes B et C du champ santé portent sur des produits à forte sensibilité fiscale ou industrielle :

Tableau 4.2 — Lignes du champ santé classées sensibles (B) ou exclues (C)

Offre	Ligne	Cat.	NPF	Désignation
CEMAC	22071010	B	5 %	-- A usages médicamenteux (*)
CEMAC	22071090	B	20 %	-- Autres (*)
CEMAC	22089010	C	30 %	-- Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volu
CEMAC	22089091	C	30 %	--- D'un titre alcoométrique volumique inférieur à 15% vol (*)
CEMAC	22089092	C	30 %	--- D'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 15%
CEMAC	30069200	C	5 %	-- Déchets pharmaceutiques
CEMAC	39231000	B	10 %	- Boîtes, caisses, casiers et articles similaires
CEMAC	39233000	B	10 %	- Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires
CEMAC	39235000	B	10 %	- Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de ferm
CEMAC	96190000	C	30 %	Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébé
Égypte	22071090	B	10 %	--- Other
Égypte	22089010	C	30 %	--- Ethyl alcohol undenatured
Égypte	22089090	C	3 000 %	--- Other
Égypte	62101010	B	20 %	--- Occupational safety or health major
Égypte	62101090	B	40 %	--- Other
Égypte	96190090	B	60 %	--- Other
Éthiopie	22089010	C	35 %	--- Ready to drink mixtures, of an alcoholic content not more
Éthiopie	22089090	C	35 %	--- Other
Éthiopie	39231000	C	20 %	-Boxes, cases, crates and similar articles of plastics
Éthiopie	39233010	B	10 %	---BOTTLE PERFORMS OF PLASTICS
Éthiopie	39233090	B	35 %	---OTHER

Offre	Ligne	Cat.	NPF	Désignation
Éthiopie	39235000	B	35 %	-Stoppers, lids, caps and other closures of plastics
Éthiopie	62101000	B	35 %	Garments, made up of fabrics of 56.02 or 56.03
Éthiopie	70109000	C	20 %	- Other
Éthiopie	96190010	B	30 %	---SANITARY TOWELS
Éthiopie	96190020	B	30 %	---TAMPONS
Éthiopie	96190030	B	20 %	---NAPKINS(DIAPERS)AND NAPKIN LINERS FOR BABIES
Éthiopie	96190090	B	30 %	---OTHER SANITARY ARTICLES
Tunisie	220710001	B	36 %	-- Pour le compte de l'Etat
Tunisie	392310100	B	30 %	-- Boîtes, caisses, casiers et articles similaires en matières
Tunisie	392310900	B	30 %	-- Autres
Tunisie	392350100	B	30 %	-- Capsules de bouchage ou de surbouchage
Tunisie	392350900	B	30 %	-- autres
Tunisie	701090611	C	30 %	----- en verre non coloré
Tunisie	701090999	B	30 %	----- Autres

Source : SaaS ZLECAF, e-Tariff Book. Égypte, 2208.90 : droit NPF de 3 000 % (spiritueux). Les emballages plastiques et le verre restent protégés dans trois offres : un surcoût direct pour le conditionnement pharmaceutique régional.

4.2 Des offres aux préférences servies

Au 27 septembre 2026, cinq destinations appliquent la ZLECAf à des origines nommément admises et selon un barème vérifiable ligne par ligne (registre d'application du SaaS) : **Afrique du Sud (SACU), Algérie, Égypte, Kenya et Maroc**. La Tunisie, l'Éthiopie, la CEDEAO et la CEMAC ont déposé une offre, mais aucune liste officielle d'origines admises n'a été trouvée. Le tableau ci-dessous donne le droit moyen réellement servi en 2026, par destination et par origine, sur trois segments clés.

Tableau 4.3 — Droit moyen servi en 2026 par destination et origine (%)

Destination (NPF)	Égypte	Algérie	Maurice	Tunisie	Afr. du Sud	Kenya	Ghana	Sénégal
Principes actifs								
Algérie (15,0 %)	0,0	—	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	15,0
Égypte (2,0 %)	—	0,1	0,1	0,1	0,8	0,8	0,8	2,0
Kenya (0,0 %)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0
Maroc (2,5 %)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
SACU (0,3 %)	0,1	0,1	0,1	0,1	—	0,1	0,1	0,1
Médicaments dosés								
Algérie (5,0 %)	0,0	—	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	5,0
Égypte (0,0 %)	—	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kenya (0,0 %)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0
Maroc (4,9 %)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
SACU (0,0 %)	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0	0,0
Instruments médicaux								
Algérie (11,2 %)	0,0	—	0,0	0,0	4,5	4,5	4,5	11,2
Égypte (4,4 %)	—	0,0	0,0	0,0	1,8	1,8	1,8	4,4
Kenya (0,0 %)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	—	0,0	0,0
Maroc (2,5 %)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
SACU (2,2 %)	0,9	0,9	0,9	0,9	—	0,9	0,9	0,9

Source : calculateurs du SaaS ZLECAf (compute_dza/egy/ken_zlecaf_rate, resolve_official_preferential_rate), barèmes 2026, moyenne simple des lignes SH6 du segment. Un taux égal au NPF signale une origine non admise par la destination (ex. Sénégal vers l'Algérie) ou une ligne hors liste servie. Maroc : droit NPF et taux servi calculés sur les lignes de l'offre (voir l'encadré).

Anomalie de données détectée pendant la production de ce rapport

Pour le Maroc, les codes nationaux à 10 chiffres du barème NPF du SaaS ne correspondent pas à ceux de l'offre ZLECAf (nomenclature LF 2025). Conséquence : le calculateur renvoie le droit NPF au lieu du taux préférentiel pour la plupart des médicaments (ex. 3004.90.00.10). Recalculé sur les lignes de l'offre, le droit servi aux origines P1 (dont l'Algérie, l'Égypte, Maurice et la Tunisie) est de **0 %** depuis 2025, et de **40 % du NPF** en 2026 pour les origines P2 (Afrique du Sud, Ghana, Kenya, Nigeria...). Le correctif est transmis à l'équipe technique.

4.3 Lecture : où la préférence crée-t-elle une marge ?

- **Algérie** : c'est la destination où la préférence pèse le plus. Principes actifs 15 % → 0 % (Égypte, Maurice, Tunisie, Tanzanie) ou 6 % (partenaires en réciprocité : Afrique du Sud, Ghana, Kenya, Cameroun) ; instruments 11,3 % → 0 % ou 4,5 %. En revanche, les origines non admises (Maroc, Nigeria, Sénégal, Côte d'Ivoire) paient le NPF.
- **Maroc** : médicaments dosés 4,9 % en moyenne (jusqu'à 25 %) → 0 % pour les origines P1. **C'est la plus forte marge sur les médicaments finis** parmi les destinations appliquées.
- **Égypte** : médicaments déjà à 0 % ; la marge porte sur les instruments (4,4 % → 0 %) et quelques principes actifs.
- **Kenya, SACU** : droits NPF déjà nuls ou quasi nuls sur le médicament ; la préférence est marginale. Au Kenya, la marge existe sur les désinfectants (35 %), les emballages (17 %) et les masques (25 %).

Conclusion opérationnelle. Pour un industriel africain, le principal gain tarifaire de la ZLECAf dans la santé est à **l'importation d'intrants** (principes actifs, verre, plastiques, dispositifs) plutôt qu'à l'exportation de médicaments finis. Cette asymétrie oriente les stratégies : localiser la formulation et le conditionnement, et sécuriser un approvisionnement en intrants d'origine africaine là où les droits NPF sont élevés.

CHAPITRE 5

Règles d'origine : ce qui rend un médicament « africain »

Pour bénéficier du taux ZLECAF, le produit doit être originaire au sens de l'Annexe 2 et de son Appendice IV (règles par produit, agréées pour tous les chapitres étudiés ici). Dans la santé, les règles sont parmi les plus souples de l'Accord : elles admettent qu'un médicament formulé en Afrique à partir de principes actifs importés d'Inde ou de Chine soit originaire.

Tableau 5.1 — Règles d'origine applicables aux produits de santé

Chapitre / position	Règle (Appendice IV, texte adopté)	Conséquence pratique
29 — Chimie organique (principes actifs)	Changement de position (CTH) ou matières non originaires ≤ 60 % du prix départ usine, ou règle de réaction chimique (note 8)	Une synthèse locale (réaction chimique) confère l'origine, même à partir d'intermédiaires importés.
30 — Produits pharmaceutiques	CTH, ou matières non originaires ≤ 60 % du prix départ usine, ou règle de réaction chimique	API importé (SH 29xx) transformé en comprimé (SH 3004) : changement de position, originaire .
38.22 — Réactifs de diagnostic	CTH ou ≤ 60 % de matières non originaires (règle du chapitre 38)	Assemblage de kits à partir de réactifs importés d'autres positions : originaire.
39 / 40 — Plastiques, gants	Ex-chapitre : CTH ou ≤ 60 %	Gants à partir de latex (4001) : originaires ; seringues (9018) : voir chapitre 90.
90 — Instruments et dispositifs	CTH ou valeur des matières non originaires ≤ 60 %	Assemblage à partir de composants de positions différentes : généralement originaire.
96.19 — Hygiène	Ex-chapitre 96 : CTH	Couches et serviettes à partir de pâte et non-tissés importés : originaires.

Source : SaaS ZLECAF, fichier zlecaf_rules_of_origin.json (Appendice IV, version de décembre 2023, statut AGREED pour les chapitres cités).

5.1 Trois pièges à éviter

- **Opérations insuffisantes (Annexe 2)** : le simple conditionnement, la mise en boîte, le mélange ou la division de lots ne confèrent jamais l'origine, même si le code SH change. Le passage d'un médicament en vrac (SH 3003) à une présentation dosée (SH 3004) par simple mise sous blister d'un produit fini importé reste une opération à risque : il faut une **vraie formulation** (granulation, compression, stérilisation, remplissage aseptique).
- **Règle des 60 %** : pour un produit à forte valeur d'API importé (biologiques, anticancéreux), l'alternative « valeur » peut échouer si l'API dépasse 60 % du prix départ usine ; la règle CTH reste alors la voie à privilégier.
- **Zones économiques spéciales** : la règle d'origine est satisfaite, mais le produit fabriqué en zone franche relève d'un régime particulier (Annexe 2, art. 9) traité au chapitre 7 à partir du cas de Maurice.

Le cumul africain : un levier sous-utilisé

L'Annexe 2 (cumul de l'origine) permet de compter comme originaires les matières d'un autre État partie. Exemple : un API égyptien ou sud-africain incorporé dans un médicament algérien, puis un flacon tunisien : tout est originaire. Dans la santé, le cumul permet surtout de sécuriser la règle des 60 % sur les produits à forte valeur d'intrants.

CHAPITRE 6

Opportunités par segment

En croisant la demande africaine (BACI, module Opportunités du SaaS), le niveau des droits NPF, le statut dans les offres et la règle d'origine, huit segments se distinguent.

Tableau 6.1 — Matrice des opportunités par segment

Segment (SH)	Demande africaine 2024	Droits NPF	Offres ZLECAF	Règle d'origine	Opportunité
Médicaments dosés (3004.90)	9,0 Md USD ; Égypte, Afr. du Sud, Maroc, Kenya	0 % dans 31 barèmes ; 5 % CEMAC, DZA, ETH ; ≤ 25 % MAR	Cat. A partout	CTH : API importé admis	Génériques essentiels pour les achats groupés (APPM) ; marge tarifaire au Maroc et en CEMAC
Antibiotiques dosés (3004.10)	0,78 Md USD ; Égypte, Nigeria, Afr. du Sud, Tanzanie	Idem	Cat. A	CTH	Injectables et formes pédiatriques, où la qualité fait la différence
Vitamines dosées (3004.50)	0,23 Md USD ; Nigeria, Côte d'Ivoire, Afr. du Sud, Ghana	Idem	Cat. A	CTH	Produits grand public en officine ; marques régionales
Vaccins vétérinaires (3002.30)	0,35 Md USD ; Égypte, Afr. du Sud, Maroc, Mozambique	0 à 5 %	Cat. A	CTH ou 60 %	Élevage sahélien et maghrébin ; chaîne du froid courte
Instruments médicaux (9018.90)	1,35 Md USD ; Afr. du Sud, Égypte, Maroc, Tunisie	0 à 10 % ; Algérie 5 à 30 %	Cat. A	CTH ou 60 %	Consommables et dispositifs de classe I-II ; forte marge en Algérie
Gants chirurgicaux (4015.11)	0,13 Md USD ; Égypte, Afr. du Sud, Maroc, Éthiopie	2 à 30 %	Cat. A	CTH (latex 40.01)	Latex africain (Côte d'Ivoire, Liberia, Nigeria) transformé localement
Hygiène (9619)	0,87 Md USD ; Afr. du Sud, Libye, Maroc, Zimbabwe	0 à 43 %	B ou C : CEMAC, Éthiopie, Égypte	CTH	Marchés protégés : préférence différée ou nulle ; produire sur place
Emballages (7010.90, 3923.30)	0,52 et 0,43 Md USD ; Afr. du Sud, Maroc, Libye	7 à 43 %	B ou C : CEMAC, Éthiopie, Tunisie	CTH	Verre et plastique pharmaceutiques : intrant stratégique des formulateurs

Sources : BACI (CEPII) via le SaaS (importations 2024 des pays africains hors Algérie) ; barèmes, offres et règles d'origine du SaaS.

6.1 Trois opportunités où la ZLECAF fait la différence

- **Dispositifs et consommables vers l'Algérie.** Les droits de 30 % sur les seringues, cathéters et gants, auxquels s'ajoute le DAPS de 30 % sur les lits médicaux et les flacons plastiques, tombent à 0 % pour les neuf origines admises (Égypte, Maurice, Tunisie, Tanzanie, Rwanda ; -60 % pour l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Ghana et le Kenya). C'est la marge préférentielle la plus élevée du champ santé parmi les destinations appliquées.
- **Médicaments vers le Maroc** pour les origines P1 (dont l'Égypte, la Tunisie, Maurice et l'Algérie) : 0 % contre 10 à 25 % sur les spécialités fabriquées localement. Le marché reste fermé de fait aux produits algériens pour des raisons politiques (chapitre 9).
- **Principes actifs vers l'Algérie** : 15 % de droit NPF sur les antibiotiques en vrac, 0 % pour les origines admises. Un producteur égyptien ou tunisien d'API, ou un chimiste mauricien, dispose d'une marge de 14,7 % de prix.

6.2 Trois opportunités où la ZLECAF ne joue pas, mais le marché si

- **Achats groupés continentaux** : le premier appel d'offres APPM (12/05/2026) a produit des économies de 30 à 90 % et retenu des fabricants africains pour 5 produits sur 10. La préférence n'est pas tarifaire mais contractuelle.
- **Relais des financements américains** : les budgets nationaux reprennent l'achat d'antirétroviraux, de tests et d'antipaludiques (protocoles de 2026).
- **Sécurité d'approvisionnement** : fret aérien depuis l'Inde en hausse de 350 à 400 %, délais allongés de 10 à 20 jours, pénuries au Kenya et au Nigeria (Pharmaceutical Commerce, 15/06/2026).

CHAPITRE 7

Étude de cas : Maurice, zones franches et ZLECAf

Maurice est le laboratoire africain des zones franches. Dès 1970, sa loi sur les zones franches d'exportation (EPZ) a fondé le décollage industriel de l'île. Aujourd'hui, son Freeport, son régime d'entreprises exportatrices et son secteur financier offshore en font un cas d'école pour trois questions que tout investisseur se pose : un produit fabriqué en zone franche bénéficie-t-il de la ZLECAf ? Que deviennent les avantages fiscaux et de change ? Et quel risque de réputation depuis le passage de Maurice sur la liste grise du GAFI ?

1970

Loi EPZ : fondation du modèle industriel exportateur
OMC, TPR WT/TPR/S/417 (2021)

268

opérateurs Freeport, ~5 500 emplois ; 797 M USD d'échanges (2023)
EDB Mauritius, consulté le 27/09/2026

3 %

taux d'IS sur les bénéfices d'exportation et en Freeport (15 % sinon)
PwC Tax Summaries, 15/06/2026

49 M USD

exportations de dispositifs médicaux en 2024 (60 % vers la France)
US ITA, 19/02/2026

Figure 7.1 — Maurice : cinquante ans de zones franches, de fiscalité et de conformité (frise non proportionnelle)



Sources : OMC TPR 2021 ; EDB ; Bank of Mauritius ; EUR-Lex (règl. délégués 2020/855 et 2022/229) ; Secrétariat ZLECAf (règl. 1/2023) ; Commission européenne (10/06/2026) ; EDB (ESAAMLG 2027).

7.1 De l'EPZ au Freeport : un modèle qui s'est normalisé

Le régime EPZ a disparu en tant que tel le **1er octobre 2006** : la Finance Act 2006 a mis fin aux certificats industriels, et les anciennes entreprises EPZ sont devenues des **entreprises exportatrices (EOE)** soumises au droit commun, avec un taux réduit de 3 % sur les bénéfices d'exportation. En 2019, les 239 EOE manufacturières employaient environ 44 000 personnes et pesaient un tiers de la valeur ajoutée manufacturière, avec une contraction continue depuis 2014 (textile surtout). Les **dispositifs médicaux et produits pharmaceutiques** figurent parmi les branches EOE citées par l'OMC.

Le **Freeport** (1992, Freeport Act n° 43 de 2004) est la vraie zone franche au sens douanier : importations en franchise de droits et de TVA, achats locaux à TVA zéro, frais portuaires réduits d'environ 50 %. Son exonération totale d'impôt sur les sociétés a été **supprimée en juin 2018** (taux de 3 % pour les nouveaux opérateurs ; maintien à 0 % jusqu'au 30 juin 2021 pour les certificats antérieurs), afin de se conformer aux standards OCDE, OMC et UE sur les régimes fiscaux dommageables. Depuis la Finance Act 2025, un **impôt minimum domestique (QDMTT, Pilier 2)** porte à 15 % l'imposition effective des groupes réalisant plus de 750 M EUR de chiffre d'affaires : l'avantage fiscal mauricien ne joue plus pour les grands laboratoires multinationaux, mais reste entier pour les PME et ETI.

Le budget 2026-2027 (19/06/2026) oriente l'île vers la recherche clinique : amendement du Clinical Trials Act pour attirer les CRO et les biotechs, cellule « Healthcare Innovation & AI », et renforcement des lois anti-blanchiment (FIAMLA, Banking Act). La synthèse budgétaire de l'EDB recense **139 certificats Freeport actifs**, contre 268 opérateurs « enregistrés » selon la page de l'EDB : l'écart entre opérateurs inscrits et actifs mesure la part de structures dormantes.

7.2 La santé à Maurice : un hub de dispositifs, pas (encore) de médicaments

Tableau 7.1 — Profil santé de Maurice

Indicateur	Valeur	Source
Fabricants de dispositifs médicaux	6 entreprises, ~1 200 emplois (stents, cathéters d'angioplastie, implants)	US ITA, 19/02/2026
Exportations d'équipements médicaux (2024)	49 M USD (France 60 %, Inde 24 %, États-Unis 5 %) ; importations 41 M USD	US ITA, 19/02/2026
Exemple d'entreprise	Natec Medical (2000), cathéters à ballonnet ; CA 2021 ≈ 16,9 M USD ; extension au Biotech Park de Côte d'Or	PNUD SDG Investor Platform ; GBC, 2023
Fabrication pharmaceutique	Une seule usine (filiale d'un groupe indien selon plusieurs sources)	US ITA, 19/02/2026
Dépendance à l'import	~75 % des médicaments importés par 48 grossistes ; Inde 39 %, France 11 %, Allemagne 7 %	US ITA, 19/02/2026
Droits NPF	0 % sur 100 % des lignes des chapitres 30 et 90 étudiées	SaaS ZLECAf, tarif MRA HS 2022
Politique industrielle	1 Md MUR (PSIP 2025/26–2029/30) pour les vaccins et la pharmacie ; congé fiscal de 8 ans	US ITA ; PNUD
Régulation	Pharmacy Act 1983 (Pharmacy Board) ; Pharmacy Council Act 2015 ; pas d'agence autonome	OMC TPR 2021

Données 2024–2026. Les chiffres du Freeport diffèrent selon les sources : EDB (797 M USD et 259 007 t en 2023) et Département d'État américain (817 M USD en 2023, 842 M USD en 2024). Nous retenons l'EDB, source primaire.

Lecture. Maurice a réussi une spécialisation de niche, celle des **dispositifs de classe III à forte valeur par kilo** (stents, cathéters), exportés par avion vers l'Europe. C'est exactement le profil de produit pour lequel une zone franche est optimale : intrants importés en franchise, valeur ajoutée technique, fret aérien marginal dans le coût. En revanche, l'île n'a pas de base de production de médicaments et reste un marché d'importation (154 M USD de médicaments dosés en 2024 selon BACI).

7.3 La ZLECAf exclut-elle les zones franches ? Non, elle les encadre

Une idée répandue veut que la ZLECAf, « comme les autres accords de libre-échange », exclue les zones franches de son champ d'application. **Les textes disent l'inverse.** Il faut distinguer trois plans :

Tableau 7.2 — Le régime ZLECAf des zones économiques spéciales

Plan	Ce que prévoient les textes	Référence
Champ territorial	Le « territoire » d'un État partie inclut sa mer territoriale ; aucune exclusion des zones franches . Les ZES sont définies comme des parties du territoire à régime plus libéral.	Annexe 2 (version janv. 2024), art. 1(u) et 1(w)
Origine	Les produits de ZES sont originaires s'ils respectent les règles de l'Annexe 2. Les produits en transit dans une ZES restent sous contrôle douanier ; en cas de transformation, un nouveau certificat est délivré.	Annexe 2, art. 9 ; Protocole commerce des marchandises, art. 23
Préférence tarifaire	Chaque État applique les tarifs préférentiels de sa liste aux produits de ZES. Aucune condition de paiement du droit NPF sur les intrants n'est posée.	Règlement ministériel 1/2023 (Gaborone, 11-12/02/2023), § 3 et 6
Garde-fous	Mesures correctives commerciales (antidumping, compensatoires, sauvegardes), protocole concurrence, clause des industries naissantes ; anti-contournement porté au règlement des différends.	Règl. 1/2023, § 7, 13 et 14 ; Annexe 9
Transparence	Notification de toutes les ZES au Secrétariat (registre), enregistrement obligatoire des entreprises exportatrices, rapport annuel, réexamen après 5 ans. Les freeports sont expressément visés.	Règl. 1/2023, § 8 à 12 et 15, note 1
Fiscalité et change	Hors du champ de l'Accord : le règlement reconnaît le pouvoir souverain des États d'accorder des incitations fiscales. Le traitement de change relève du droit national.	Règl. 1/2023, préambule
Points encore ouverts	Les « critères et questions relatifs aux ZES » de l'art. 9 figurent toujours parmi les travaux en suspens.	Annexe 2, art. 42

Sources : Annexe 2 mise à jour (au-afcfta.org, janv. 2024) ; Règlement ministériel 1/2023, texte signé (tralac). Aucune décision postérieure du Conseil des ministres sur les ZES n'a été identifiée au 27/09/2026.

Pourquoi la confusion ? Deux notions de « territoire »

En droit douanier national, une zone franche est traitée comme hors du territoire douanier (Convention de Kyoto révisée, annexe spécifique D) : une marchandise qui en sort vers le marché intérieur est une **importation**, taxée comme telle. C'est vrai à Maurice comme en Algérie (loi 22-15).

En droit de la ZLECAf, la zone franche fait partie du territoire de l'État partie : le produit qui en sort vers un **autre** État partie peut revendiquer l'origine et la préférence. Ces deux logiques se cumulent ; elles ne se contredisent pas.

7.4 Les autres accords de Maurice : même logique d'encadrement

Tableau 7.3 — Zones franches et accords commerciaux de Maurice

Accord	En vigueur	Traitement des zones franches	Statut de vérification
ZLECAF	ratifiée le 30/09/2019	Admises sous conditions (art. 9, règl. 1/2023)	Texte lu
ALE Maurice-Chine	01/01/2021	Aucune clause spécifique ; règles d'origine générales (valeur régionale ≥ 40 %), transit ≤ 6 mois	Texte intégral recherché
CECPA Maurice-Inde	01/04/2021	Les autorités des ZES indiennes sont habilitées à délivrer les certificats d'origine : produits de ZES admis s'ils sont originaires	Texte lu
APE intérimaire UE (AfoA)	14/05/2012 ; approfondissement conclu le 10/06/2026	Protocoles d'origine UE : article type « zones franches » (contrôle douanier, non-substitution)	Clause type ; texte APE non relu
SADC, COMESA	—	Clauses de traitement des EPZ	Non vérifié

Sources : textes des accords (MCCI, MRA), Commission européenne, OMC TPR 2021.

Ce qui change vraiment pour l'opérateur en zone franche, c'est la **discipline de preuve** : comptabilité matières séparée, traçabilité des intrants non originaires, respect de la règle de produit (CTH ou 60 %), enregistrement auprès de l'autorité compétente. Un opérateur Freeport qui se contente de stocker, reconditionner et réexporter des produits asiatiques **ne crée pas d'origine** (opérations insuffisantes) et n'obtient aucune préférence.

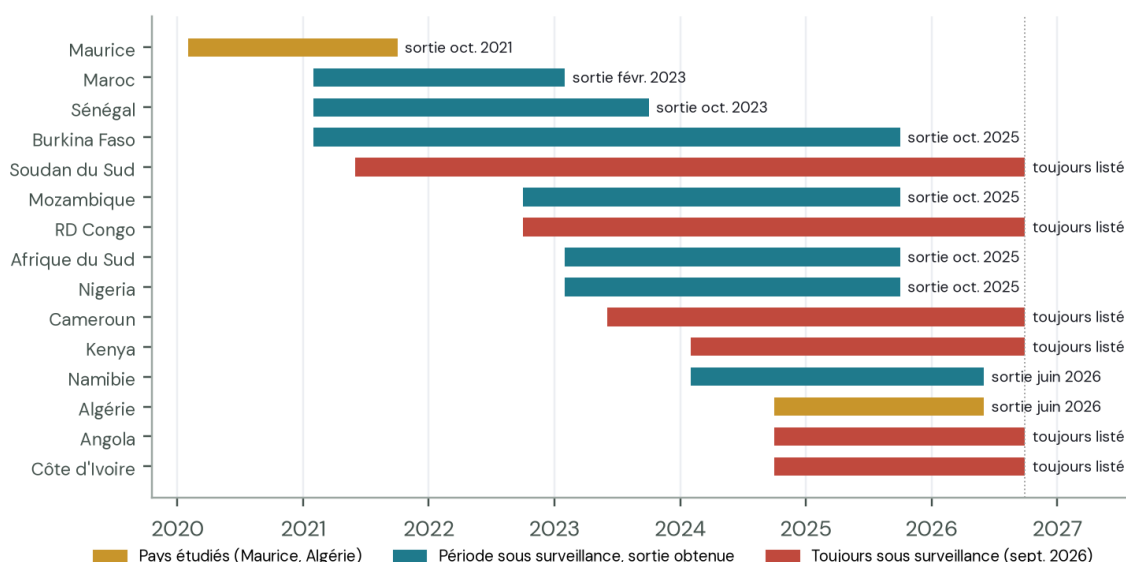
7.5 Fiscalité et change : l'avantage mauricien face à la ZLECAF

- **Change** : l'Exchange Control Act est suspendu depuis **juillet 1994** ; aucune restriction sur les opérations courantes ni en capital, roupie flottante. Un opérateur peut facturer, encaisser et conserver des devises sans délai de rapatriement. C'est l'écart le plus net avec l'Algérie (délai de rapatriement ramené à 120 jours par le règlement 26-02 du 23/07/2026).
- **Fiscalité** : 3 % sur les bénéfices d'exportation (maintenu par le budget 2026-2027), 80 % d'exonération partielle sur certains revenus étrangers, mais QDMTT à 15 % pour les grands groupes et « Fair Share Contribution » temporaire (2 % pour les sociétés au taux réduit, 2025-2028).
- **Risque ZLECAF** : un avantage fiscal **subordonné à l'exportation** est, par nature, susceptible d'être contesté par des droits compensateurs (Annexe 9, règl. 1/2023 § 13). Le risque est aujourd'hui théorique pour les dispositifs médicaux (droits NPF nuls dans la plupart des destinations), mais il existe sur les marchés à droits élevés.

7.6 GAFI : la sortie de liste grise, un actif de conformité

Maurice a été placée sous **surveillance renforcée du GAFI en février 2020** et en est sortie le **21 octobre 2021**. L'Union européenne l'avait inscrite sur sa liste des pays tiers à haut risque (applicable au 1er octobre 2020) et l'en a retirée par le règlement délégué (UE) 2022/229 (en vigueur le 13 mars 2022). Au 27 septembre 2026, Maurice ne figure ni sur la liste grise du GAFI (plénière de juin 2026, 22 juridictions), ni sur les listes fiscales de l'UE (annexes I et II, mise à jour du 17/02/2026). Sa prochaine évaluation mutuelle par l'ESAAMLG commencera en **2027**, après une mission préparatoire du 14 au 18 décembre 2026 (L'Express, repris par allAfrica, 15/09/2026) ; la ministre des Services financiers y voit « un test important de notre juridiction » (Le Mauricien, 25/03/2026).

Figure 7.2 — Pays africains sous surveillance renforcée du GAFI, 2020–2026



Sources : communiqués du GAFI (plénières de février, juin et octobre), Bank of Mauritius, Trésor sud-africain (24/10/2025), ComplyAdvantage (22/06/2026). Dates de plénière ; la page officielle du GAFI de juin 2026 a été consultée par recoupement.

Pourquoi c'est important dans la pharmacie. Un pays en liste grise subit des diligences renforcées de ses banques correspondantes : lettres de crédit plus chères et plus lentes, refus de certaines opérations, surcoût de conformité. Pour un laboratoire qui répond à des appels d'offres de centrales d'achat (UNICEF, Fonds mondial, centrales nationales), ces frictions pèsent directement sur la compétitivité. Six pays africains restent sur la liste en septembre 2026 : Angola, Cameroun, Côte d'Ivoire, RD Congo, Kenya et Soudan du Sud. **L'Algérie en est sortie le 19 juin 2026**, mais reste sur la liste européenne des pays à haut risque (règlement délégué 2025/1184) tant que la Commission ne l'a pas retirée : aucun retrait n'était confirmé au 27/09/2026.

Note terminologique

GAFI (Groupe d'action financière, FATF en anglais) : organe intergouvernemental de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ; sa « liste grise » recense les juridictions sous surveillance renforcée. À ne pas confondre avec la **GAFTA/ZALE** (Grande zone arabe de libre-échange), accord commercial dont l'Algérie est membre, mais pas Maurice.

7.7 Scénario chiffré : un cathéter mauricien vers l'Algérie

Maurice figure parmi les neuf origines admises par l'Algérie (calendrier standard). Un cathéter fabriqué à Maurice (SH 9018.39), originaire, entre donc en Algérie en liste A, à droit nul en 2026. Le calcul ci-dessous, établi avec le calculateur fiscal algérien du SaaS, compare deux fournisseurs pour une valeur en douane de 100.

Tableau 7.4 — Cathéter (SH 9018.39.10) importé en Algérie, septembre 2026

Élément (base : valeur CAF = 100)	Origine hors ZLECAf (NPF)	Origine Maurice (ZLECAf)
Droit de douane	30,0	0,0
DAPS	0,0	0,0
PRCT (2 %)	2,0	2,0
Charge hors TVA (coût définitif)	32,0	2,0
TVA 19 % (récupérable par un assujetti)	25,1	19,4
Charge totale à l'importation	57,1	21,4

Source : SaaS ZLECAf (compute_dza_zlecaf_rate, relevé DGD, circulaire 482/2024). Hypothèses : produit originaire (règle du chapitre 90 : CTH ou ≤ 60 % de matières non originaires), certificat d'origine ZLECAf, opérateur Freeport enregistré conformément au règlement 1/2023.

- **Marge préférentielle : 30 points de valeur CAF.** Un fabricant mauricien peut vendre jusqu'à **29 % plus cher** (132/102 – 1) qu'un concurrent hors ZLECAf et rester au même coût rendu hors TVA.
- **Piège de la règle d'origine :** les parties de cathéters relèvent elles-mêmes de la position 90.18. Un assemblage à partir de composants importés de 90.18 ne satisfait pas le changement de position : il faut alors respecter le critère des 60 % de matières non originaires, ce qui exige un calcul de prix de revient documenté.
- **Barrière réelle :** l'enregistrement du dispositif auprès de l'ANPP et le programme d'importation du ministère algérien, plus déterminants que le droit de douane.

CHAPITRE 8

Focus Algérie : de la substitution à l'export

En quinze ans, l'Algérie est passée d'une couverture de 40 % à 83 % de ses besoins en médicaments par la production locale, et sa facture d'importation a été divisée par quatre depuis 2019. La question stratégique n'est plus « produire pour le marché national » mais « exporter vers un continent qui importe 9 milliards de dollars de médicaments dosés par an ». Ce chapitre chiffre les leviers et les obstacles, avec les outils du SaaS (calculateur fiscal DGD, barèmes ZLECAf, module Opportunités, sous-module « Algérie · industrie et marchés »).

83 %

couverture des besoins en médicaments par la production nationale (fin 2025)
ANPP, 22/02/2026 ; projet de politique pharmaceutique nationale, août 2026 (82 %)

233

établissements de production pharmaceutique, dont 138 fabriquent des médicaments
Ministère de l'Industrie pharmaceutique, nov. 2025

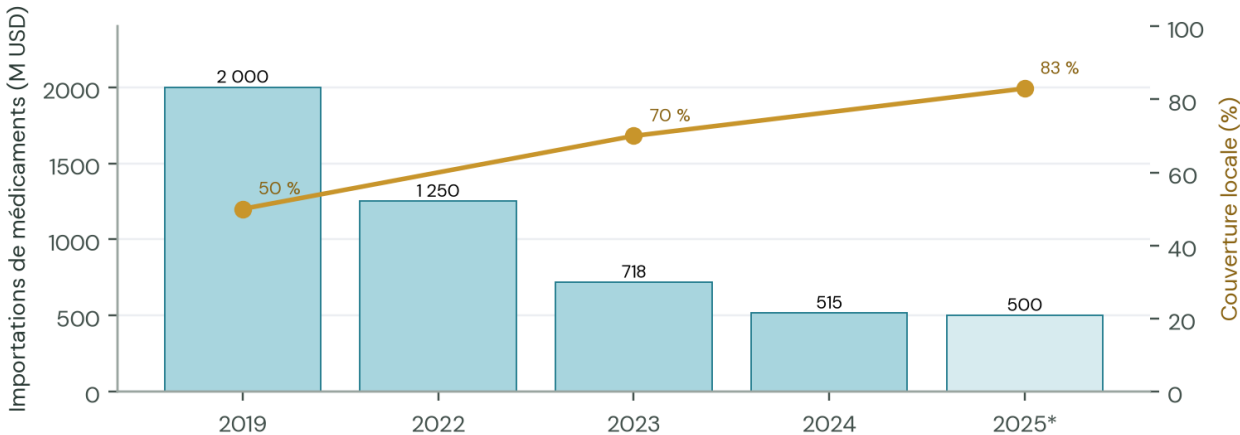
515 M USD

importations de médicaments en 2024 (2 000 M USD en 2019)
Horizons, 01/02/2026

23,3 M USD

exportations de médicaments dosés en 2024, dont 18,8 % vers l'Afrique
BACI via SaaS (dza_filières.json)

Figure 8.1 — Substitution aux importations : facture d'import et taux de couverture locale



Sources : Horizons (01/02 et 19/06/2026), ANPP (22/02/2026). *2025 : ordre de grandeur cité par la presse, pas de chiffre définitif des Douanes.

8.1 Une base industrielle devenue significative

Tableau 8.1 — Principaux industriels

Acteur	Statut	Capacité ou fait marquant	Source
Saidal	Public	144 M d'unités de vente produites en 2025 ; exporte vers 10 pays (Tunisie, Libye, Mauritanie, Sénégal, Tchad, Mali, Burkina Faso...) ; ~220 produits ciblés en Mauritanie ; accord de 100 M USD avec un groupe nigérian (IATF 2025)	SaaS dza_filières ; La Voie d'Algérie
Saidal (suite)	Public	Accords de fabrication avec Boehringer Ingelheim (fibrose pulmonaire, 08/06/2026) et Novo Nordisk (GLP-1, 30/06/2026) ; relance de l'unité de solvants de Médéa après 20 ans d'arrêt ; 6e fabricant africain, CA estimé à 320-360 M USD	Algérie Eco ; Just-InfoDZ, 24/09/2026 ; Maghreb Emergent, 27/09/2026
Biopharm	Privé	65,8 M de boîtes produites en 2024 ; 7e fabricant africain (CA estimé à 300-350 M USD)	Rapport annuel 2024 ; Maghreb Emergent, 27/09/2026
Novo Nordisk (Boufarik, Tizi Ouzou)	Filiale	17 M de stylos à insuline en 2023 (capacité 45 M) ; 2,5 M de stylos exportés vers l'Arabie saoudite en 2024	SaaS dza_filières ; Algérie Eco
Biothéra (Biocare Biotech)	Privé	10 M de boîtes de 5 stylos d'insuline glargine par an (capacité) ; protocole d'export d'insulines vers le tunisien Dorcas (20/05/2026)	MIPH ; Esseha, 22/05/2026
Frater-Razes et Sanofi	Privé	Transfert technologique complet pour des insulines de nouvelle génération ; l'insuline importée coûtait ~420 M EUR par an	Maghreb Emergent, 30/04/2026

Acteur	Statut	Capacité ou fait marquant	Source
Hikma Pharma Algérie	Filiale	5 sites dont injectables (Staouéli) et oncologie	Algérie Eco, 17/06/2025
Sanofi (Sidi Abdellah)	Filiale	Plus de 100 M d'unités par an, premier site du groupe en Afrique	L'Usine Nouvelle
El Kendi (MS Pharma), Frater-Razes, Merinal	Privés	Objectif d'export de 5 M USD en 2026 (El Kendi) ; présence déclarée dans 22 pays (Frater-Razes)	APS ; Esseha

Sources : SaaS, sous-module « Algérie · industrie et marchés » (fiches SH 3004), complété par la presse économique algérienne. Chiffres d'entreprise non audités par nos soins.

Annonces et réalisations : lire la presse avec méthode. Le nombre d'usines varie de 178 (liste officielle d'agrément, déc. 2025) à 200 (L'Algérie Aujourd'hui, 16/04/2026), 218 (El Watan, 08/09/2025), 233 (ministre, nov. 2025) et « environ 250 » (Horizons, 14/07/2026) ; le taux de couverture de 79 à 83 %. Les exportations pharmaceutiques 2024 sont de **23,3 M USD selon BACI** (médicaments dosés) et de **46 M USD selon El Watan (08/09/2025) et Horizons (19/06/2026)**, qui retiennent un périmètre plus large ; aucun chiffre 2025 n'est publié. En face, les annonces sont d'un autre ordre : 400 M USD de contrats pharmaceutiques « attendus » à l'IATF 2025 (El Watan), 11,4 Md USD d'accords algériens tous secteurs selon Afreximbank (Le Jeune Indépendant, 06/09/2026). Les calendriers glissent : le niveau 3 de l'OMS, « attendu en octobre 2025 » (El Watan), est désormais en évaluation depuis septembre 2026 ; les usines de vaccins d'Annaba et d'anticancéreux de Constantine sont repoussées à fin 2027, et Saidal a nommé un second directeur général le 14/07/2026 pour « rattraper les retards » (Le Matin d'Algérie, 16/08/2026 ; Algérie Eco, 14/07/2026). **Nos calculs retiennent les chiffres réalisés, jamais les annonces.**

8.2 Le régime à l'importation : ce que la ZLECAf change pour l'industriel algérien

Toutes les lignes de santé étudiées sont en **liste A** de la circulaire DGD 482/2024 : droit nul en 2026 pour les origines du calendrier standard (Égypte, Maurice, Rwanda, Tanzanie, Tunisie), réduit de 60 % pour les partenaires en réciprocité (Afrique du Sud, Cameroun, Ghana, Kenya). Le **DAPS** (30 % sur les flacons plastiques et le mobilier médical) est levé pour les produits originaires des partenaires.

Le cadre administratif pèse autant que la fiscalité. Au printemps 2026, 52 médicaments étaient en tension (La Nouvelle République, 06/04/2026) et le ministre a donné de 48 heures à 5 jours aux fabricants et importateurs pour libérer leurs stocks, sous peine de retrait d'agrément (TSA, 04/04/2026) ; le média relie ce risque à l'instabilité au Moyen-Orient. La plateforme des programmes prévisionnels d'importation a rouvert pour le second semestre du 23/06 au 31/07/2026 (TSA, 23/06/2026). Enfin, l'ANPP propose de plafonner l'enregistrement à trois génériques et deux biosimilaires par spécialité, ce que l'association des producteurs (SAARPE) juge porteur de monopoles et de désinvestissement (TSA, 14/09/2026).

Tableau 8.2 — Charge fiscale à l'importation en Algérie, en % de la valeur CAF, septembre 2026

Produit (SH)	DD NPF	Charge NPF hors TVA	ZLECAf standard	ZLECAf réciprocité	Commentaire
Antibiotiques en vrac (2941.90)	15 %	17,0 %	2,0 %	8,0 %	Intrant clé ; plus taxé que le médicament fini
Médicaments dosés (3004.90)	5 %	7,0 %	2,0 %	4,0 %	Importation encadrée : programme prévisionnel, interdiction des produits fabriqués localement
Insuline dosée (3004.31)	5 %	7,0 %	2,0 %	4,0 %	Production locale (Boufarik, Biothéra)
Seringues (9018.31)	30 %	32,0 %	2,0 %	14,0 %	Forte protection des producteurs locaux
Cathéters, perfusion (9018.39)	30 %	32,0 %	2,0 %	14,0 %	Voir le cas mauricien (§ 7.7)
Gants chirurgicaux (4015.12)	30 %	35,0 %	5,0 %	17,0 %	TCS 3 % maintenue
Réactifs de diagnostic (3822.19)	5 %	10,0 %	5,0 %	7,0 %	
Flacons plastiques (3923.30)	30 % + DAPS 30 %	65,0 %	5,0 %	17,0 %	DAPS levé sous ZLECAf
Flacons verre ≤ 0,15 l (7010.90)	15 %	20,0 %	5,0 %	11,0 %	Conditionnement des injectables
Lits médicaux (9402.90)	30 % + DAPS 30 %	65,0 %	5,0 %	17,0 %	DAPS levé sous ZLECAf

Source : SaaS ZLECAf, calculateur fiscal algérien (relevé DGD, LF 2026, circulaire 482/2024 ; compute_dza_zlecaf_rate, daps_exempt). Charge hors TVA = DD + DAPS + PRCT (2 %) + TCS (3 %, si applicable). TVA exclue : récupérable pour un industriel assujetti ; les médicaments à usage humain bénéficient en principe d'une exonération (le relevé affiche 9 % sur les lignes vétérinaires). Réciprocité : DD réduit de 60 % en 2026.

8.3 Hypothèse de travail n° 1 : la protection effective négative

Le taux de protection effective (TPE) mesure la protection de la **valeur ajoutée** d'un producteur, et non celle du prix : $TPE = (t_{\text{produit}} - a \times t_{\text{intrant}}) / (1 - a)$, où *a* est la part de l'intrant importé dans le prix du produit. Avec 7 % de charge sur le médicament fini et 17 % sur l'API importé hors ZLECAf :

Tableau 8.3 — Protection effective de la formulation locale selon l'origine de l'API

Part de l'API dans le prix (a)	API hors ZLECAf (17 %)	API ZLECAf réciprocité (8 %)	API ZLECAf standard (2 %)
20 %	4,5 %	6,8 %	8,2 %
35 %	1,6 %	6,5 %	9,7 %
50 %	-3,0 %	6,0 %	12,0 %
60 %	-8,0 %	5,5 %	14,5 %

Calcul : ZLECAf Trade Intelligence, sur les charges hors TVA du tableau 8.2. Hypothèse simplificatrice : un seul intrant importé ; les emballages (20 à 65 % de charge) aggravent le résultat.

Lecture. Pour les produits où l'API pèse la moitié du prix (antibiotiques injectables, génériques de spécialité), le formulateur algérien est **moins protégé que l'importateur du produit fini (TPE de -3 % à -8 %)**. S'approvisionner en API d'origine ZLECAf retourne la situation : la TPE monte à +12 à +15 %. En prix, un API originaire d'un partenaire du calendrier standard peut coûter jusqu'à **14,7 % de plus** que l'API indien ou chinois avant de perdre son avantage (8,3 % pour un partenaire en réciprocité). Deux correctifs existent hors ZLECAf : le régime de **perfectionnement actif**

(suspension des droits sur les intrants réexportés) et une révision du tarif des API, qui relève de la loi de finances.

Une escalade à rebours peut-être assumée. L'Algérie importe 98 % de ses principes actifs (Maghreb Emergent, 30/04/2026) et environ 3 Md USD de matières premières pharmaceutiques par an ; le gouvernement vise 2,7 Md USD d'économies d'ici 2028 grâce à onze unités, dont cinq de Sidal en construction (Observ'Algérie, 08/04/2026). L'unité de solvants de Médéa, qui produit l'acétate de butyle nécessaire à la pénicilline G, a redémarré en septembre (Just-InfoDZ, 24/09/2026), et un mémorandum prévoit d'exporter vers la Tunisie des matières premières pour le paracétamol et les antibiotiques (Algérie Eco, 03/02/2026). Le droit de 15 % sur les API protège donc aussi une filière chimique naissante. Le dilemme est réel : chaque point de protection des futurs producteurs d'API est payé par les formulateurs d'aujourd'hui. La ZLECAf permet de le desserrer sans toucher au tarif NPF, en admettant à 0 % les API des partenaires africains.

8.4 Les marchés d'exportation : où la demande et la préférence se rencontrent

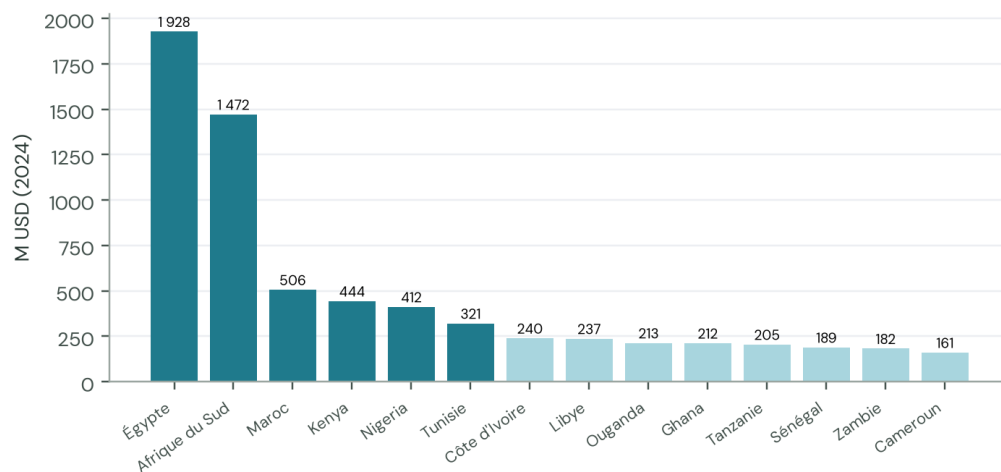
Tableau 8.4 — Quatorze premiers marchés africains des médicaments dosés (SH 3004.90) et accès pour l'origine Algérie

Marché	Import. 2024 (M USD)	Part Algérie	Droit NPF médic.	Droit servi (orig. DZA)	Application ZLECAF	GAFI (juin 2026)
Égypte	1 928	0 %	0,0 %	0	oui (5 ans)	—
Afrique du Sud	1 472	0,2 %	0,0 %	0	oui (réciprocité)	—
Maroc	506	0 %	4,9 % (≤ 25 %)	0 (P1)	oui (P1)	—
Kenya	444	0 %	0,0 %	0 (NPF)	non (hors annexe 1)	liste grise
Nigeria	412	0 %	0,0 %	0 (NPF)	offre seule	—
Tunisie	321	0,1 %	0,0 %	0 (NPF)	offre seule	—
Côte d'Ivoire	240	0,1 %	0,0 %	0 (NPF)	offre seule	liste grise
Libye	237	0 %	n.d.	n.d.	non ratifiée	—
Ouganda	213	0 %	0,0 %	0 (NPF)	non appliquée	—
Ghana	212	0 %	0,0 %	0 (NPF)	offre seule	—
Tanzanie	205	0 %	0,0 %	0 (NPF)	non appliquée	—
Sénégal	189	0,3 %	0,0 %	0 (NPF)	offre seule	—
Zambie	182	0 %	n.d.	n.d.	offre seule	—
Cameroun	161	0 %	5,0 %	5 (NPF)	offre seule	liste grise

Sources : BACI (CEPII) via le module Opportunités du SaaS (dza_commerce_baci.json, importations des pays africains, hors Algérie) ; barèmes et calculateurs du SaaS ; GAFI (plénière de juin 2026). Maroc : droit NPF moyen de l'offre (4,9 %, jusqu'à 25 %). « Offre seule » : offre déposée à l'UA, sans liste d'origines admises vérifiée.

Trois constats. (i) La demande africaine de médicaments dosés atteint **9,0 Md USD en 2024** (SH 3004.90 seul), concentrée à 60 % sur six marchés ; l'Algérie en détient une part infime. (ii) Sur les marchés où la ZLECAF s'applique, la préférence n'apporte une marge qu'au **Maroc**, marché fermé de fait par la rupture diplomatique de 2021. (iii) Partout ailleurs, l'Algérie concourt à armes tarifaires égales avec l'Inde : la compétitivité se jouera sur le coût rendu, le délai, l'enregistrement et le financement.

Ce que révèlent les contrats signés. La presse dessine une géographie de proximité, cohérente avec notre matrice de risque (chapitre 9). **Mauritanie** : cinq contrats de 10 M USD avec le distributeur King Pharma et ses filiales au Mali et au Sénégal (Algérie Eco, 29/11/2025), accord Sidal-Chinguitty Pharma (Maghreb Emergent, 24/05/2025), 27 accords à la foire de Nouakchott, où le ministre mauritanien de la Santé s'est engagé à débloquer les enregistrements en retard de Sidal (Algérie Patriotique, 08/05/2026 ; Le Jour d'Algérie, 05/2026). **Libye** : appel d'offres de 950 M EUR pour l'importation de médicaments, auquel le ministère invite les producteurs algériens (L'Algérie Aujourd'hui, 16/04/2026). **Niger** : mémorandum ANPP-agence nigérienne en finalisation et étude d'unités de production au Niger (Horizons, 24/03/2026), groupe de travail Sidal-ambassade (Algérie Patriotique, 02/09/2026). **Tunisie** : export d'insulines Biocare vers Dorcas (Esseha, 22/05/2026). **Égypte** : mémorandum ANPP-EDA ouvrant la voie à une reconnaissance mutuelle (L'Écho d'Algérie, 15/06/2026). Point commun : **le levier est réglementaire (enregistrement) et commercial (distributeur local), jamais tarifaire**, ce que confirment nos calculs.

Figure 8.2 — Importations africaines de médicaments dosés (SH 3004.90), 2024, M USD

Source : BACI (CEPII) via le SaaS, module Opportunités. Six premiers marchés en couleur foncée.

8.5 Cas chiffré : génériques algériens contre génériques indiens à Dakar

Hypothèses : conteneur de 40' de génériques secs (comprimés, gélules) d'une valeur FOB de 300 000 USD ; droit NPF sénégalais nul pour les deux origines (TEC CEDEAO, catégorie O) ; coût du capital de l'importateur de 12 % par an ; stock de sécurité égal à la moitié du délai de transit. L'hypothèse d'une desserte maritime régulière Alger-Dakar s'appuie sur les nouvelles lignes CNAN et GATMA vers Nouakchott et Dakar (Horizons, 19/03/2026) ; Air Algérie Cargo dessert Nouakchott, Dakar et N'Djamena, avec un fret aérien en hausse de plus de 25 % en 2025 (Algérie Eco, 10/04/2026).

Tableau 8.5 — Coût rendu Dakar d'un conteneur de génériques

Poste	Inde (Nhava Sheva → Dakar)	Algérie (Alger → Dakar)	Écart
Fret maritime, surcharges 2026 comprises	4 000 \$	1 430 \$	2 570 \$
Délai de transit, jours (stock de sécurité)	32 (16)	12 (6)	-20 (-10)
Assurance transport (0,35 % / 0,25 %)	1 050 \$	750 \$	300 \$
Portage financier du stock en transit et de sécurité	4 734 \$	1 775 \$	2 959 \$
Droits de douane (NPF = ZLECAf)	0 \$	0 \$	0 \$
Total des coûts de rendu hors prix	9 784 \$	3 955 \$	5 829 \$ (1,9 %)

Hypothèses : fret Inde → Afrique de l'Ouest 2026 de l'ordre de 3 000 à 4 000 USD par conteneur de 40' (transitaires), plus surcharges de conflit et de carburant ; Alger → Dakar modélisé par le SaaS (logistics_fees_data, 955 USD par EVP, soit ×1,5 pour un 40') avec transbordement. Calcul : ZLECAf Trade Intelligence.

Tableau 8.6 — Sensibilité : avantage de coût rendu de l'origine Algérie (% de la valeur FOB)

Fret Inde → Dakar (USD / 40')	Transit 25 j	Transit 32 j	Transit 40 j
3 000	1,3 %	1,6 %	2,0 %
4 000	1,6 %	1,9 %	2,3 %
5 000	1,9 %	2,3 %	2,7 %
6 000	2,3 %	2,6 %	3,0 %

Conclusion. La proximité vaut **1,3 à 3 % de la valeur** : c'est l'écart de prix FOB maximal que le génériqueur algérien peut se permettre face à l'Inde, à tarif égal. L'avantage triple pour un conteneur de 100 000 USD (5,8 %) et se dilue à 1,0 % pour 600 000 USD : il est décisif sur les produits volumineux et à faible valeur (solutés, sirops, pansements, consommables), marginal sur les spécialités. Or les génériques indiens sont souvent 20 à 40 % moins chers : **la proximité ne compense pas un écart de prix industriel**. Elle se valorise surtout en fiabilité (délais courts, réassort, moindre exposition aux crises maritimes de 2026).

8.6 Contraintes financières et de conformité

Tableau 8.7 — Environnement financier et réglementaire de l'exportateur pharmaceutique algérien

Dimension	Situation au 27/09/2026	Effet pour l'exportateur
GAFI	Sortie de la liste grise le 19/06/2026 (inscrite en oct. 2024)	Allègement progressif des diligences bancaires ; argument commercial auprès des centrales d'achat
Liste UE des pays à haut risque	Inscription par le règl. délégué (UE) 2025/1184 ; retrait non confirmé	Diligences renforcées maintenues par les banques européennes (financement, confirmation de crédits documentaires)
Rapatriement des recettes	Règl. Banque d'Algérie 26-02 du 23/07/2026 : 120 jours (180 avec assurance-crédit CAGEX), contre 360 auparavant	Incompatible avec les délais de paiement publics africains (90 à 180 jours) sans assurance-crédit
Disposition des devises	Instruction O6-2021 : 100 % des recettes hors hydrocarbures à disposition de l'exportateur (maintien sous 26-02 à confirmer)	Permet de financer les intrants importés
Assurance-crédit	CAGEX : couverture obligatoire entre 120 et 180 jours (Algérie Eco, 23/08/2026) ; engagements > 46 Md DA, dont 15 % en Afrique ; mémorandums avec COTUNACE, ECIC et SONAC	La prime doit être intégrée au prix export
Réseau bancaire	Algerian Union Bank (Nouakchott, 3 agences), Algerian Bank of Senegal (Dakar) ; succursale au Niger demandée pour fin 2026-début 2027, Côte d'Ivoire envisagée (L'Express DZ, 10/05/2026)	Encaissement local ; commerce Algérie-Mauritanie d'environ 500 M USD par an
Zones franches	Loi 22-15 ; zone franche commerciale de Tindouf (décret 24-169), réception attendue en 2026	Plateforme vers la Mauritanie ; zones prévues avec la Tunisie, la Libye, le Mali et le Niger non créées
Régulation	Évaluation OMS « niveau de maturité 3 » de l'ANPP à partir de sept. 2026	Condition des procédures accélérées d'enregistrement dans les pays tiers
Importations	Suspension des nouveaux agréments d'importation (23/04/2026)	Aucune (export) ; freine les partenariats d'import-substitution croisés

Sources : GAFI ; Commission européenne (IP/25/1378) ; Banque d'Algérie (règl. 26-02, instr. O6-2021) ; CAGEX (27/03/2026) ; APS ; Ministère des Finances ; décret 24-169 ; L'Algérie Aujourd'hui (07/06/2026) ; Algérie Eco (25/04/2026).

8.7 Scénarios 2027 pour les exportations pharmaceutiques

Tableau 8.8 — Scénarios d'exportation

Scénario	Hypothèses	Exportations 2027 (ordre de grandeur)
Tendanciel	Croissance 2023-2024 amortie ; Arabie saoudite et Maghreb dominants ; pas de niveau 3 OMS	30 à 50 M USD
Africain	Niveau 3 OMS obtenu ; enregistrements accélérés en Afrique de l'Ouest (Mauritanie, Sénégal, Mali via l'axe Tindouf) ; contrats IATF exécutés à 20 %	80 à 150 M USD
Intégré ZLECAF	Scénario africain + API d'origine africaine, perfectionnement actif, assurance-crédit généralisée, présence dans les appels d'offres groupés	150 à 250 M USD

Scénarios construits par ZLECAF Trade Intelligence : ce sont des ordres de grandeur conditionnels, pas des prévisions. Base 2024 : 23,3 M USD (BACI), 46 M USD selon la presse (périmètre large). Intentions IATF 2025 annoncées : plus de 725 M USD, non ventilées.

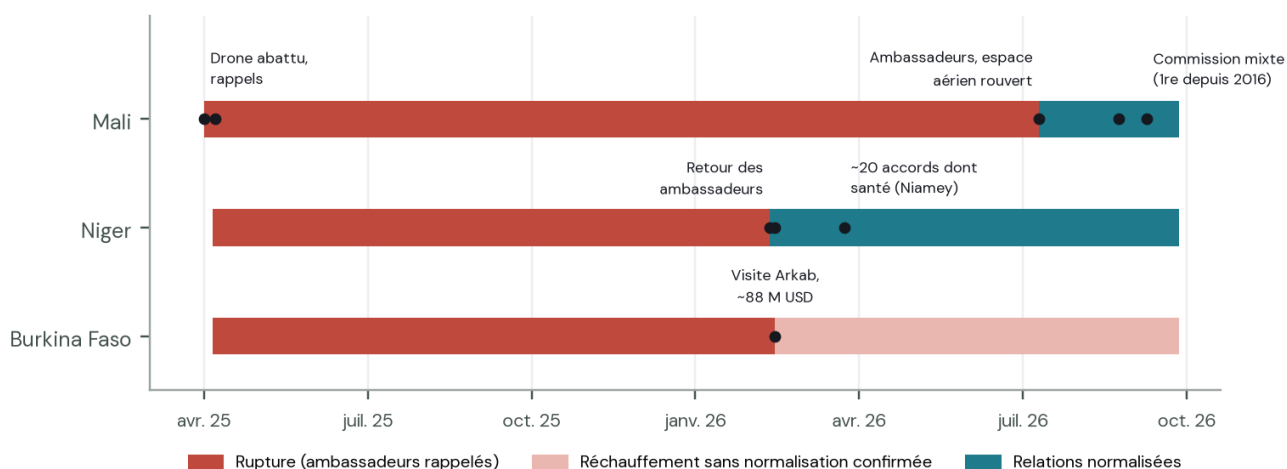
CHAPITRE 9

Turbulences politiques et chaînes d'approvisionnement

Dans la santé, le risque politique ne se mesure pas seulement en droits de douane. Il se traduit par des frontières fermées, des espaces aériens interdits, des blocus routiers, des sanctions et des guerres maritimes qui décident de la disponibilité d'un médicament. Pour l'exportateur algérien, 2026 est une année de bascule : la normalisation avec le Sahel rouvre des corridors, tandis que les crises d'Ormuz et de la mer Rouge rebattent la géographie du fret.

9.1 Algérie-Sahel : du gel d'avril 2025 à la normalisation de 2026

Figure 9.1 — Relations de l'Algérie avec les États de l'AES, avril 2025 à septembre 2026



Sources : Al Jazeera (11/07/2026), Bloomberg (10/07/2026), ISS Africa (16/03/2026), Atalayar (13/02/2026), ActuNiger (02/2026), Military Africa (04/2026), La Nouvelle Tribune (09/2026), Maliexpress (17/09/2026). Burkina Faso : programme de ~88 M USD selon une source unique ; retour formel des ambassadeurs non documenté.

La crise s'ouvre dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, quand l'armée algérienne abat un drone malien près de Tinzaouatène (La Nouvelle Tribune, 09/2026). Le Mali, le Niger et le Burkina Faso rappellent leurs ambassadeurs par solidarité au sein de l'AES ; Alger ferme son espace aérien au Mali le 7 avril 2025. La sortie de crise se fait pays par pays. Avec le **Niger**, les ambassadeurs reviennent le 12 février 2026 (Atalayar, 13/02/2026) ; la visite du général Tiani à Alger (15-16 février) relance le gazoduc transsaharien, la route transsaharienne et la fibre optique, et Sonelgaz s'engage sur une centrale de 40 MW à Niamey (ActuNiger, 02/2026). À Niamey, les 23-24 mars, une vingtaine d'accords sont signés, dont un volet **santé** dont le contenu n'a pas été publié (Military Africa, 04/2026). Avec le **Mali**, la normalisation est plus tardive : ambassadeurs et espace aérien rétablis les 10-12 juillet 2026 (Bloomberg, 10/07/2026), visite à Alger du Premier ministre Abdoulaye Maïga les 24-25 août (Algérie Patriotique, 23/08/2026), puis 13e Grande Commission mixte à Bamako en septembre, la première depuis 2016 (La Nouvelle Tribune, 09/2026).

Ce que cela change pour le médicament algérien. La session de 2016 de la commission mixte algéro-malienne comprenait déjà un volet santé : c'est le cadre naturel pour négocier une reconnaissance des enregistrements de l'ANPP et un accès aux achats publics maliens. L'espace aérien rouvert rend possible le fret aérien direct Alger-Bamako pour les produits de la chaîne du froid (insuline, vaccins). Mais trois réserves pèsent : (i) **aucun accord commercial ou pharmaceutique chiffré** n'a été publié avec le Mali (Maliexpress, 17/09/2026) ; (ii) la réouverture des postes frontières terrestres n'est confirmée par aucune source ; (iii) le **blocus du JNIM** autour de Bamako, réimposé le 28 avril 2026 et toujours actif fin août, rend incertaine toute logistique routière vers le Mali par le sud. La presse sahélienne parle d'ailleurs d'un « voisinage négocié » plutôt que d'une réconciliation (Sahel Tribune, 2026) : le risque de réversibilité plaide pour des contrats courts, couverts par l'assurance-crédit. Avec le Niger, la normalisation se traduit déjà dans la santé : memorandum entre agences du médicament en finalisation (Horizons, 24/03/2026) et groupe de travail Saidal sur l'approvisionnement et le transfert de technologie (Algérie Patriotique, 02/09/2026).

9.2 Voisinage et grands partenaires : une carte en recomposition

Tableau 9.1 — Relations extérieures de l'Algérie et effets sur la filière santé

Relation	État au 27/09/2026	Conséquence pour la santé
Maroc	Relations rompues depuis le 24/08/2021, espace aérien fermé, frontière fermée depuis 1994, gazoduc GME arrêté (ICG ; Al Jazeera, 22/07/2026)	Le seul marché où la ZLECAf donne une marge au médicament algérien (0 % contre jusqu'à 25 %) reste fermé de fait ; l'axe terrestre vers l'Afrique de l'Ouest passe par la Mauritanie.
Mauritanie	Route Tindouf–Zouérate ouverte à la circulation (piste en partie non revêtue), postes frontières fixes, zone franche de Tindouf (décret 24-169)	Premier débouché naturel : ~220 produits Sidal ciblés, Algerian Union Bank à Nouakchott, contrats King Pharma avec filiales au Mali et au Sénégal (Algérie Eco, 29/11/2025).
Tunisie, Libye	Mécanisme tripartite Égypte–Algérie–Tunisie relancé en janvier 2026 ; Libye divisée, affrontements à Zawiya (mai et septembre 2026)	Tunisie : partenaire admis par l'Algérie (0 % sur les API tunisiens). Libye : marché de 237 M USD de médicaments (BACI 2024), non ratifiant de la ZLECAf.
France	Dégel partiel : retour de l'ambassadeur en mai 2026, visites ministérielles de février à juin ; relation qualifiée de « rupture structurelle » (France 24, 08/05/2026)	Aucune restriction visant les produits pharmaceutiques français identifiée ; Sanofi reste le premier site du groupe en Afrique.
Espagne	Reprise des échanges en novembre 2024, traité d'amitié réactivé en mars 2026, visite de P. Sánchez le 20/07/2026 (France 24)	Réouverture d'une source d'équipements et de consommables européens.
Émirats arabes unis	Rupture des relations diplomatiques le 10/09/2026 (Bloomberg ; Al Jazeera ; AP)	Risque sur les hubs de Dubaï et Jebel Ali (déjà perturbés par Ormuz) pour les flux de réexportation et les paiements ; impact commercial non encore documenté.
Chine	Levée des droits chinois sur les importations algériennes jusqu'en 2028 annoncée à compter du 01/05/2026 (source unique, à vérifier)	Sans effet direct sur la pharmacie ; la Chine reste le premier fournisseur mondial de principes actifs.

Sources citées dans le tableau. Synthèse et lecture : ZLECAf Trade Intelligence.

9.3 Instabilité en Afrique : où le risque politique touche le médicament

Tableau 9.2 — Foyers d'instabilité 2025–2026 et accès aux produits de santé

Pays	Événement	Effet sur l'accès aux produits de santé
Mali, Niger, Burkina Faso	Suspendus de l'UA ; sortis de la CEDEAO (janv. 2025) ; prélèvement AES de 0,5 % sur les importations CEDEAO, aide humanitaire exemptée (Premium Times, 03/2025)	Ils appliquent encore le TEC CEDEAO (médicaments à 0 %). Négociation CEDEAO–AES jusqu'à fin 2026 : l'origine algérienne n'est pas pénalisée par ce prélèvement.
Madagascar	Coup d'État du 12/10/2025 ; suspendu de l'UA	Marché de 93 M USD (SH 3004.90, BACI 2024) ; risque de paiement.
Guinée-Bissau	Coup d'État du 26/11/2025 ; élections annoncées pour le 06/12/2026	Marché marginal ; risque de rupture de contrats publics.
Bénin	Tentative de coup d'État déjouée le 07/12/2025	Stabilité maintenue ; corridor Cotonou–Niamey inchangé.
Tanzanie	Violences post-électorales (oct. 2025) : 518 morts selon la commission, bilan contesté	Partenaire admis par l'Algérie ; frontières kényanes renforcées.
Cameroun	Crise post-électorale (au moins 48 morts, ONU) ; liste grise du GAFI	Marché CEMAC à 5 % de droit NPF ; paiements sous diligence renforcée.
Soudan	Guerre depuis avril 2023 ; 37 % des établissements de santé à l'arrêt (OMS, 09/01/2026)	Besoin humanitaire massif ; accès par les agences de l'ONU uniquement.
RD Congo (Est)	Accords de Doha et de Washington enlisés ; pourparlers de Genève (09/2026)	Liste grise du GAFI ; logistique vers l'Est très coûteuse.
Éthiopie-Érythrée	Risque de guerre élevé en 2026 (The New Humanitarian, 23/02/2026)	Premier marché d'Afrique de l'Est par la population ; droit NPF de 5 % sur les médicaments.

Sources : Union africaine (communiqués des 27/11 et 07/12/2025), Amani Africa (26/02/2026), The Citizen (2026), OMS, Al Jazeera, Chatham House, BACI via SaaS. Suspensions UA au 26/02/2026 : Burkina Faso, Guinée-Bissau, Madagascar, Mali, Niger, Soudan.

9.4 Chocs extérieurs : quatre décisions qui redessinent le marché

- **Fin de l'USAID et nouvelle stratégie sanitaire américaine.** Les protocoles « America First Global Health Strategy » signés avec 24 pays africains prévoient que Washington finance 100 % des produits en 2026, puis une part décroissante (Kenya : 2,5 Md USD dont 1,6 Md USD américains ; Nigeria : 2 Md USD américains contre ~3 Md USD nationaux sur 2026–2030 ; KFF, Semafor 09/03/2026). **Un marché de substitution s'ouvre à mesure que les budgets nationaux prennent le relais** : antirétroviraux, antipaludiques, tests.
- **Droits de douane américains.** Section 232 : 100 % sur les médicaments et API brevetés depuis le 31/07 ou le 29/09/2026 selon les entreprises ; génériques et biosimilaires exemptés pour l'instant. Section 301 (« travail forcé ») : **12,5 % sur les importations d'origine algérienne depuis le 24/07/2026** (Al Jazeera, 24/07/2026). Le marché américain n'est pas une cible pour le générique algérien ; l'Afrique et le Golfe le sont d'autant plus.
- **AGOA renouvelé rétroactivement le 03/02/2026 jusqu'au 31/12/2026 seulement (USTR)** : les fabricants d'Afrique subsaharienne qui visent les États-Unis restent dans l'incertitude ; l'Algérie n'y est pas éligible.
- **Ormuz et mer Rouge.** Ormuz est de fait fermé depuis le 28/02/2026 ; les Houthis ont repris leurs attaques en juillet et atteint l'île de Perim en septembre. Les principes actifs indiens et chinois renchérissent (fret, assurance, délais) ; les **ports méditerranéens algériens et la route transsaharienne**, qui ne dépendent ni de Suez ni d'Ormuz, gagnent un avantage relatif pour desservir l'Afrique de l'Ouest.

9.5 Matrice de risque des marchés cibles pour l'exportateur algérien

Tableau 9.3 — Matrice de risque des marchés cibles (septembre 2026)

Marché	Relation avec l'Algérie	Stabilité intérieure	Accès ZLECAF (orig. DZA)	GAFI (juin 2026)	Logistique depuis l'Algérie	Appréciation
Mauritanie	Très bonne	Stable	NPF (non appliquée)	—	Route Tindouf-Zouérate, mer	Priorité 1
Tunisie	Très bonne	Stable	NPF 0 % ; partenaire admis	—	Route, mer	Priorité 1
Niger	Normalisée (fév. 2026)	Transition militaire	NPF 0 % (TEC CEDEAO)	—	Transsaharienne	Priorité 2
Sénégal	Bonne	Stable ; Coface dégradé à C (17/02/2026)	NPF 0 %	—	Mer, Tindouf-Zouérate	Priorité 2
Mali	Normalisée (juil. 2026)	Blocus JNIM de Bamako	NPF 0 %	—	Air ; route incertaine	Opportuniste
Côte d'Ivoire	Bonne	Stable	NPF 0 %	Liste grise	Mer	Priorité 2
Nigeria	Bonne (gazoduc TSGP)	Tensions sécuritaires	NPF 0 % ; hors partenaires admis	—	Mer	Priorité 2
Cameroun	Partenaire en réciprocité	Crise post-électorale	NPF 5 % (offre non appliquée)	Liste grise	Mer	Priorité 3
Libye	Bonne	Division, affrontements	Non ratifiante	—	Route, mer	Opportuniste
Égypte	Bonne	Stable	0 % (appliquée, NPF déjà nul)	—	Mer	Concurrent direct
Kenya	Partenaire en réciprocité	Manifestations récurrentes	Origine DZA non admise	Liste grise	Mer (via Suez perturbé)	Priorité 3
Maroc	Rompue	Stable	0 % (P1) mais marché fermé de fait	—	Fermée	Bloqué

Appréciation qualitative de ZLECAF Trade Intelligence, fondée sur les chapitres 4, 7, 8 et 9. Coface (baromètre du 17/02/2026) : seule la note du Sénégal a été vérifiée. Les notes de risque d'autres organismes (ACLED, assureurs-crédit) sont à consulter avant tout engagement.

CHAPITRE 10

Recommandations

Les recommandations sont hiérarchisées par acteur. Elles découlent des calculs des chapitres 3 à 9 et visent un horizon de 12 à 24 mois.

Acteur	Recommandation	Levier chiffré	Horizon
Industriel algérien	Sourcer les principes actifs et le verre auprès d'origines ZLECAF du calendrier standard (Égypte, Tunisie) ; à défaut, activer le perfectionnement actif pour la production exportée	Jusqu'à 14,7 % de prime de prix supportable sur l'API ; TPE de -3 % à +12 % (a = 50 %)	6-12 mois
Industriel algérien	Cibler d'abord les produits volumineux à faible valeur (solutés, sirops, pansements, consommables) en Afrique de l'Ouest, où la proximité pèse le plus	Avantage de coût rendu de 1,3 à 3 % (jusqu'à 5,8 % pour un conteneur de 100 000 USD)	12 mois
Industriel algérien	Adosser chaque contrat africain à une assurance-crédit CAGEX pour porter le délai de rapatriement à 180 jours	Règl. 26-02 : 120 jours sans assurance	Immédiat
ANPP et MIPH	Obtenir le niveau de maturité 3 de l'OMS et négocier des procédures d'enregistrement fondées sur la confiance réglementaire avec la Mauritanie, le Sénégal, le Mali et le Niger	Délai d'enregistrement : premier obstacle, avant le droit de douane	2026-2027
Pouvoirs publics algériens	Corriger l'escalade à rebours : aligner les API (15 %) sur le médicament fini (5 %) ou les exonérer sous condition de fabrication locale	Supprime la protection effective négative	LF 2027
Pouvoirs publics algériens	Élargir la liste des partenaires admis (neuf origines aujourd'hui) aux pays d'Afrique de l'Ouest pour obtenir la réciprocité sur les marchés d'export	Condition d'accès aux préférences servies	12 mois
Opérateur mauricien	Enregistrer l'entreprise Freeport au titre du règlement 1/2023, documenter l'origine (critère des 60 % pour les dispositifs de 90.18) et cibler l'Algérie et le Maroc	Marge de 30 points sur les cathéters en Algérie ; 0 % au Maroc (P1)	6 mois
Investisseur (tous pays)	Évaluer une implantation en zone franche sous l'angle de l'origine ZLECAF, pas seulement de la fiscalité : un simple reconditionnement ne crée pas d'origine	Préférence nulle sans transformation suffisante	Avant investissement
Banques et assureurs	Intégrer la sortie de la liste grise du GAFI (Algérie, juin 2026) dans les politiques de risque pays, et suivre le retrait de la liste de l'UE	Coût de confirmation des crédits documentaires	Immédiat
Centrales d'achat africaines	Utiliser les préférences ZLECAF sur les dispositifs et consommables (droits de 10 à 35 %) dans les achats groupés	Économie directe sur le coût rendu	12 mois

Source : ZLECAF Trade Intelligence, à partir des calculs du rapport.

ANNEXE

Annexe 1 — Tableau de bord santé des 54 pays

Pour chaque État : régime tarifaire, statut ZLECAF, droit NPF moyen mesuré par le SaaS sur quatre segments de santé, et statut GAFI après la plénière de juin 2026. Les 14 pays sans barème national intégré au SaaS sont signalés « n.i. » ; leur tarif est alors celui de leur union douanière, le cas échéant.

Pays	Régime tarifaire	Ratif.	Offre (UA)	Application	Médic. dosés	Principes actifs	Instruments	Gants	GAFI
Afrique du Sud	TEC SACU	Oui	Via SACU	Appliquée	0,0	0,3	2,2	7,5	—
Algérie	National	Oui	Offre adoptée	Appliquée	5,0	15,0	10,0	30,0	—
Angola	National	Oui	Adoptée prov.	—	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	Liste grise
Botswana	TEC SACU	Oui	Offre adoptée	—	0,0	0,3	2,2	7,5	—
Burkina Faso	TEC CEDEAO	Oui	Offre adoptée	—	0,0	5,0	5,0	6,2	—
Burundi	TEC CAE	Oui	Offre adoptée	—	0,0	0,0	0,0	2,5	—
Bénin	TEC CEDEAO	Non	Offre adoptée	—	0,0	5,0	5,0	6,2	—
Cabo Verde	TEC CEDEAO	Oui	Offre adoptée	—	0,0	5,0	5,0	6,2	—
Cameroun	TEC CEMAC	Oui	Offre adoptée	—	5,0	8,3	5,0	11,2	Liste grise
Centrafrique	TEC CEMAC	Oui	Offre adoptée	—	5,0	8,3	5,0	11,2	—
Comores	National	Oui	Offre adoptée	—	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	—
Congo	TEC CEMAC	Oui	Offre adoptée	—	5,0	8,3	5,0	11,2	—
Côte d'Ivoire	TEC CEDEAO	Oui	Offre adoptée	Liste requise	0,0	5,0	5,0	6,2	Liste grise
Djibouti	National	Oui	—	—	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	—
Eswatini	TEC SACU	Oui	Offre adoptée	—	0,0	0,3	2,2	7,5	—
Gabon	TEC CEMAC	Oui	Offre adoptée	—	5,0	8,3	5,0	11,2	—
Gambie	TEC CEDEAO	Oui	Offre adoptée	—	0,0	5,0	5,0	6,2	—
Ghana	TEC CEDEAO	Oui	Offre adoptée	—	0,0	5,0	5,0	6,2	—
Guinée	TEC CEDEAO	Oui	Offre adoptée	—	0,0	5,0	5,0	6,2	—
Guinée équatoriale	TEC CEMAC	Oui	Offre adoptée	—	5,0	8,3	5,0	11,2	—
Guinée-Bissau	TEC CEDEAO	Oui	Offre adoptée	—	0,0	5,0	5,0	6,2	—
Kenya	TEC CAE	Oui	Offre adoptée	Appliquée	0,0	0,0	0,0	2,5	Liste grise
Lesotho	TEC SACU	Oui	Offre adoptée	—	0,0	0,3	2,2	7,5	—
Liberia	TEC CEDEAO	Oui	Offre adoptée	—	0,0	5,0	5,0	6,2	—
Libye	National	Non	—	—	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	—
Madagascar	National	Oui	Offre adoptée	—	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	—
Malawi	National	Oui	Offre adoptée	—	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	—
Mali	TEC CEDEAO	Oui	Offre adoptée	—	0,0	5,0	5,0	6,2	—
Maroc	National	Oui	Offre adoptée	Appliquée	9,4	2,5	2,5	9,4	—
Maurice	National	Oui	Offre adoptée	—	0,0	0,0	0,0	3,8	—
Mauritanie	National	Oui	Offre adoptée	—	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	—
Mozambique	National	Oui	Autre décl.	—	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	—
Namibie	TEC SACU	Oui	Offre adoptée	—	0,0	0,3	2,2	7,5	—
Niger	TEC CEDEAO	Oui	Offre adoptée	—	0,0	5,0	5,0	6,2	—
Nigeria	TEC CEDEAO	Oui	Offre adoptée	Liste requise	0,0	5,0	5,0	6,2	—
Ouganda	TEC CAE	Oui	Offre adoptée	—	0,0	0,0	0,0	2,5	—
RD Congo	TEC CAE	Oui	Offre adoptée	—	0,0	0,0	0,0	2,5	Liste grise
Rwanda	TEC CAE	Oui	Offre adoptée	—	0,0	0,0	0,0	2,5	—
Seychelles	National	Oui	Offre adoptée	—	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	—

Pays	Régime tarifaire	Ratif.	Offre (UA)	Applicatio n	Médic. dosés	Principes actifs	Instrume nts	Gants	GAFI
Sierra Leone	TEC CEDEAO	Oui	Offre adoptée	—	0,0	5,0	5,0	6,2	—
Somalie	TEC CAE	Oui	—	—	0,0	0,0	0,0	2,5	—
Soudan	National	Non	—	—	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	—
Soudan du Sud	TEC CAE	Non	Offre adoptée	—	0,0	0,0	0,0	2,5	Liste grise
São Tomé-et-Príncipe	National	Oui	—	—	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	—
Sénégal	TEC CEDEAO	Oui	Offre adoptée	—	0,0	5,0	5,0	6,2	—
Tanzanie	TEC CAE	Oui	Offre adoptée	—	0,0	0,0	0,0	2,5	—
Tchad	TEC CEMAC	Oui	Offre adoptée	—	5,0	8,3	5,0	11,2	—
Togo	TEC CEDEAO	Oui	Offre adoptée	—	0,0	5,0	5,0	6,2	—
Tunisie	National	Oui	Soumise	—	0,0	0,0	4,7	30,0	—
Zambie	National	Oui	Offre adoptée	Liste requis	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	—
Zimbabwe	National	Oui	Liste prov.	—	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	—
Égypte	National	Oui	Offre adoptée	Appliquée	0,0	2,0	4,4	6,0	—
Érythrée	National	Non signé	—	—	n.i.	n.i.	n.i.	n.i.	—
Éthiopie	National	Oui	Offre adoptée	Liste requis	5,0	2,9	0,0	—	—

n.i. : barème national non intégré au SaaS. Droits NPF moyens en % (moyenne simple des lignes SH6 : médicaments dosés 30.04 ; principes actifs 29.36-29.41 ; instruments 90.18-90.20 ; gants 40.14-40.15). GAFI : juridictions sous surveillance renforcée après la plénière du 19/06/2026. Sources : SaaS ZLECAF (barèmes, e-Tariff Book UA, statuts au 13/09/2026, registre d'application), tralac, GAFI.

ANNEXE

Annexe 2 — Note méthodologique

Élément	Méthode et hypothèses
Périmètre produit	15 segments de santé définis par préfixes SH (tableau 3.1) : principes actifs (29.36–29.41), produits du sang et vaccins (30.01–30.02), médicaments en vrac (30.03) et dosés (30.04), pansements et articles pharmaceutiques (30.05–30.06), réactifs (38.22), désinfectants (3808.94, 2207.10, 2208.90), gants (40.14–40.15), instruments (90.18–90.20), orthopédie (90.21), imagerie (90.22), mobilier (94.02), hygiène (96.19), emballages (70.10, 39.23) et textiles médicaux (6307.90, 6210.10). Rattachement d'une ligne au préfixe le plus long.
Droits NPF	40 barèmes nationaux du SaaS (5 463 lignes SH6 dans le périmètre). Moyenne simple des lignes, sans pondération par les échanges. Lorsqu'une ligne SH6 comporte des sous-positions nationales à taux différents, le taux retenu est celui de la ligne SH6 (ou de la première sous-position, pour l'Algérie et le Maroc). Le Maroc est présenté soit sur son barème national (chapitre 3), soit sur les lignes de son offre (chapitres 4 et 8), comme indiqué.
Catégories d'offre	Instantanés e-Tariff Book (UA) collectés les 17/08 et 13/09/2026 : CEMAC, CAE, CEDEAO, Égypte, Éthiopie, Maroc, Tunisie, Zambie, Zimbabwe (plus le barème SARS pour la SACU). Une offre est « OFFER_ONLY » tant qu'aucun acte national et aucune liste d'origines admises ne sont vérifiés.
Taux servis	Calculateurs du SaaS (compute_dza_zlecaf_rate, compute_egy_zlecaf_rate, compute_ken_zlecaf_rate, resolve_official_preferential_rate) au 27/09/2026, année 2026. Un taux n'est servi que si la destination a un acte d'application en vigueur, admet l'origine et couvre la ligne ; à défaut, le NPF est retenu. Le taux servi est plafonné au NPF.
Charge fiscale algérienne	Calculateur du SaaS : DD (ou taux ZLECAF) + DAPS (levé pour les listes A/B sous ZLECAF) + PRCT 2 % + TCS 3 % (lignes concernées) ; TVA calculée sur la base majorée, mais exclue des comparaisons (récupérable pour un industriel ; exonération de principe des médicaments à usage humain).
Protection effective	$TPE = (t_p - a \cdot t_i) / (1 - a)$, avec $t_p = 7\%$ (médicament fini, DD + PRCT) et $t_i = 17\%, 8\%$ ou 2% selon l'origine de l'API. Un seul intrant importé ; hypothèse prudente.
Coût rendu (cas 8.5)	Valeur FOB 300 000 USD par conteneur de 40' ; fret Inde 4 000 USD (sensibilité 3 000–6 000) ; Alger-Dakar 1 430 USD (SaaS, 955 USD par EVP × 1,5) ; assurance 0,35 % et 0,25 % ; coût du capital 12 % ; stock de sécurité égal à la moitié du transit. L'avantage calculé est l'écart de prix FOB maximal supportable par l'origine Algérie à droits égaux.
Demande	BACI (CEPII) via le module Opportunités du SaaS (dza_commerce_baci.json), importations 2024 des pays africains hors Algérie, en USD courants. Les exportations algériennes proviennent du même fichier et du sous-module « Algérie · industrie et marchés » (dza_filieres.json), qui signale ses propres contradictions de sources.
Sources externes	Chaque chiffre externe est daté et sourcé : GAFI, EUR-Lex, Secrétariat ZLECAF (Annexe 2, règlement 1/2023), OMC (TPR Maurice 2021), EDB, MRA, PwC, US ITA, Banque d'Algérie, ANPP, MIPH, APS et presse économique. Les informations non confirmées en source primaire sont signalées dans le texte.
Limites	Les taux ne tiennent pas compte des exonérations au cas par cas (marchés publics, dons, programmes nationaux), des prix administrés ni des délais d'enregistrement, souvent plus déterminants que le droit de douane dans la santé. Les scénarios sont des ordres de grandeur conditionnels, pas des prévisions.

ANNEXE

Annexe 3 — Lexique

AMA — Agence africaine du médicament, créée par traité (en vigueur depuis novembre 2021), siége à Kigali.

AMM — Autorisation de mise sur le marché d'un médicament, délivrée par l'autorité nationale (ANPP en Algérie).

ANPP — Agence nationale des produits pharmaceutiques (Algérie).

API / principe actif — Substance active d'un médicament (SH 29 pour l'essentiel), par opposition aux excipients.

Biosimilaire — Médicament biologique similaire à un produit de référence dont le brevet a expiré.

CAGEX — Compagnie algérienne d'assurance et de garantie des exportations.

Catégorie A / B / C — Classement des lignes dans les offres ZLECAF : libéralisées (90 %), sensibles (7 %), exclues (3 %).

Certificat d'origine — Document prouvant qu'un produit est originaire au sens de l'Annexe 2 ; condition du taux préférentiel.

CTH — Changement de position tarifaire (4 chiffres) entre les matières non originaires et le produit fini.

Cumul — Possibilité de compter comme originaires les matières d'un autre État partie.

DAPS — Droit additionnel provisoire de sauvegarde (Algérie, 30 à 200 %), levé pour les listes A/B sous ZLECAF.

DCI — Dénomination commune internationale d'une substance (ex. amoxicilline).

Dispositif médical — Instrument, appareil ou matériel à usage médical (SH 90.18 à 90.22 surtout), classé de I à III selon le risque.

e-Tariff Book — Base officielle de l'UA des offres tarifaires ZLECAF.

EOE — Export Oriented Enterprise : statut des anciennes entreprises EPZ mauriciennes depuis 2006.

EPZ — Export Processing Zone : zone franche d'exportation (Maurice, 1970-2006).

Freeport — Zone franche douanière de Maurice (1992 ; Freeport Act 2004).

GAFI / FATF — Groupe d'action financière ; sa « liste grise » recense les juridictions sous surveillance renforcée.

GAFTA / ZALE — Grande zone arabe de libre-échange ; distincte du GAFI.

GMP / BPF — Bonnes pratiques de fabrication, condition d'agrément des usines.

Liste A (Algérie) — Lignes démantelées selon la circulaire DGD 482/2024 : 0 % en 2026 (calendrier standard).

Niveau de maturité 3 (OMS) — Niveau de l'outil GBT de l'OMS attestant un système de réglementation stable et fonctionnel.

NPF — Nation la plus favorisée : droit appliqué à toute origine hors préférence.

Opérations insuffisantes — Opérations (conditionnement, mélange, étiquetage...) qui ne confèrent jamais l'origine.

P1 / P2 (Maroc) — Listes d'origines admises par le Maroc : démantèlement en 5 ans (P1) ou 10 ans (P2) depuis 2021.

Perfectionnement actif — Régime douanier suspendant les droits sur des intrants transformés puis réexportés.

PCH — Pharmacie centrale des hôpitaux (Algérie).

Pilier 2 / QDMMT — Impôt minimum mondial de 15 % pour les groupes > 750 M EUR ; version domestique qualifiée.

PRCT — Prélèvement de 2 % à l'importation en Algérie.

Préqualification OMS — Évaluation de l'OMS ouvrant l'accès aux achats des agences des Nations unies.

Protection effective — Protection de la valeur ajoutée d'un producteur, compte tenu des droits sur ses intrants.

Réciprocité (Algérie) — Calendrier plus lent appliqué à l'Afrique du Sud, au Cameroun, au Ghana et au Kenya.

Règlement 1/2023 — Règlement ministériel ZLECAF sur le traitement des produits des zones économiques spéciales.

SH — Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (OMD).

TCS — Taxe de solidarité de 3 % à l'importation sur certaines lignes en Algérie.

TEC — Tarif extérieur commun d'une union douanière (CEDEAO, CAE, CEMAC, SACU).

TPE — Taux de protection effective (voir Protection effective).

ZES — Zone économique spéciale : partie du territoire à régime douanier, fiscal ou réglementaire dérogatoire.

Zone franche — Espace réputé hors du territoire douanier national : les ventes vers le marché intérieur y sont des importations.